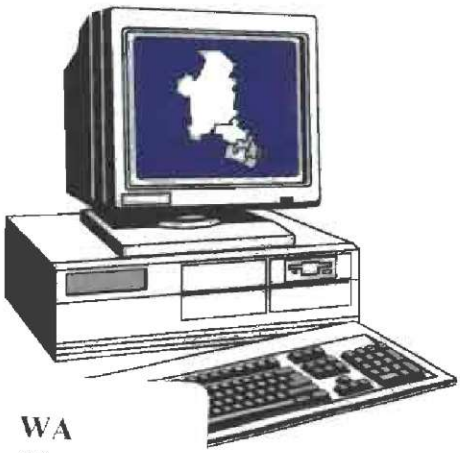
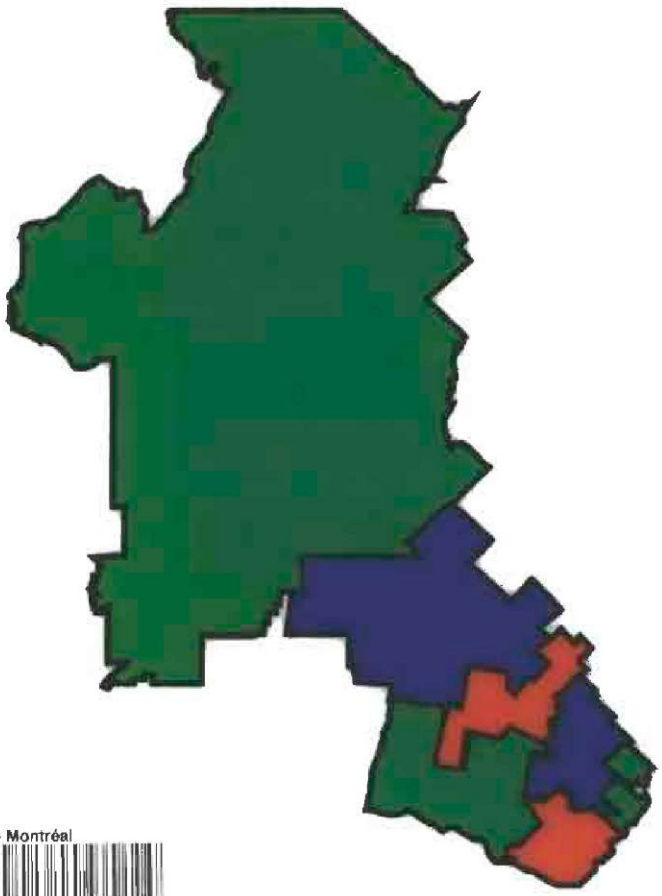
RÉGIE RÉGIONALE
DE LA SANTÉ ET DES
SERVICES SOCIAUX
DES LAURENTIDES

DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

RAPPORT SUR LES MALADIES À DECLARATION OBLIGATOIRE REGION DES LAURENTIDES





WA
55
L387
1996

INSPQ - Montréal
3 5567 00010 8487

1996

I 12,021
Ex.2

Institut national de santé publique du Québec
4835, avenue Christophe-Colomb, bureau 200
Montréal (Québec) H2J 3G8
Tél.: (514) 597-0608

RAPPORT SUR LES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE (Maladies infectieuses)

RÉGION DES LAURENTIDES ANNÉE 1996

Sylvie Provost, m.d.
Jean-Luc Grenier, m.d.

Direction de la santé publique des Laurentides

Avril 1997

WA
55
L387
1996

SANTECOM

ISBN 2-921581-59-0
Dépôts légaux, 2e trimestre 1997
Bibliothèque nationale du Canada
Bibliothèque nationale du Québec

TABLE DES MATIÈRES

Remerciements i

Introduction 1

Méthodologie 3

Limites de l'analyse 5

Portrait-synthèse MADO-Laurentides 1996 7

Discussion et recommandations 19

Conclusion 23

Graphiques illustrant certaines MADO :

- Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année, Laurentides et province de Québec, 1990-1996 27
- Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année, par CLSC, Laurentides, 1994-1996 27
- Répartition des déclarations selon les maladies infectieuses, Laurentides, 1996 28
- Maladies transmises sexuellement et/ou par le sang contaminé 30
  - Chlamydiose génitale 31
  - Infection gonococcique génito-urinaire 33
  - Hépatite B aiguë 35
  - Sida 37
- Maladies transmises par voie respiratoire 39
  - Coqueluche 41
  - Scarlatine 44
  - Infection à méningocoque 47
  - Rougeole 49
  - Tuberculose 51

- Maladies transmises par voie fécale-orale 53
  - Éclosion de gastro-entérite 55
  - Campylobactériose 56
  - Salmonellose 59
  - Giardiase 62
  - Entérite à *E. Coli* pathogène 65
  - Yersiniose 68
  - Hépatite A 71

- La rage 73

Tableaux :

- Nombre de cas déclarés par année, Laurentides et province de Québec, 1994-1996 76
- Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année, Laurentides et province de Québec, 1994-1996 78
- Nombre de cas déclarés par CLSC, Laurentides, 1996 80
- Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année, par CLSC Laurentides, 1996 81
- Nombre de cas déclarés par mois, Laurentides, 1996 82
- Nombre de cas déclarés selon l'âge et le sexe, Laurentides, 1996 83
- Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année, selon l'âge et le sexe, Laurentides, 1996 85

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier tous les médecins et laboratoires qui ont déclaré les cas de maladies à déclaration obligatoire (MADO). Ce rapport est essentiellement basé sur les données qu'ils nous ont communiquées.

Au sein de la Direction de la santé publique des Laurentides, nous remercions le Dr Pierre Robillard, coordonnateur de l'équipe de maladies infectieuses, ainsi que le Dr Denise Décarie, médecin-conseil en maladies infectieuses, pour leur collaboration lors de l'élaboration de ce rapport. Nos remerciements vont aussi à Mme Céline Lachapelle pour le traitement de texte et la mise en page de ce document.

Enfin nous remercions pour leur excellente collaboration les infirmières en milieu scolaire et les coordonnateurs et coordonnatrices des CLSC du territoire, de même que les pharmaciens des centres hospitaliers, pour toutes les occasions où leur participation aux mesures de contrôle des MADO a été sollicitée.

INTRODUCTION

Le rapport sur les maladies à déclaration obligatoire 1996 pour la région des Laurentides s'inscrit dans la lignée des rapports publiés en 1993, 1994 et 1995. Comme dans les rapports précédents, seules les données sur les maladies à déclaration obligatoire (MADO) de nature infectieuse, prévues dans le règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique, sont présentées dans ce document.

Comparativement aux rapports des années précédentes, le rapport MADO 1996 constitue une version abrégée du bilan des MADO dans les Laurentides. En effet, la section "Analyse descriptive de certaines MADO" qu'on retrouvait dans les rapports MADO précédents a été réduite à son expression visuelle. Les données concernant certaines MADO d'intérêt sont donc présentées graphiquement, alors que la section portrait-synthèse regroupe les commentaires écrits sur ces MADO, de façon à éviter la répétition d'information.

Après une description de la méthodologie utilisée et des limites de l'analyse proposée, ce rapport propose un portrait-synthèse de la situation des MADO dans les Laurentides en 1996 incluant une brève description des interventions entreprises dans le contrôle de certaines maladies infectieuses sur notre territoire. Suivent une brève discussion des résultats et les recommandations qui en découlent. La section qui suit illustre sous forme graphique les données concernant certaines MADO, regroupées en grandes catégories. La dernière section présente les données MADO 1996 pour les Laurentides sous forme de tableaux. Les premiers tableaux illustrent l'ensemble des MADO pour notre région pour les années 1994 à 1996, en comparaison avec les données provinciales. Les tableaux suivants contiennent les données MADO 1996, pour notre région, selon le CLSC, selon le mois, selon l'âge et le sexe.

Nous rappelons au lecteur que les médecins et les laboratoires sont responsables de la déclaration des MADO auprès des Directeurs régionaux de santé publique. Ces derniers doivent transmettre les informations recueillies au ministère de la Santé et des Services sociaux. La déclaration de ces maladies vise essentiellement deux objectifs. Le signalement d'une maladie à déclaration obligatoire (MADO) permet dans un premier temps de mettre en branle le plus rapidement possible l'intervention de santé publique visant à prévenir la survenue de cas secondaires. Selon la maladie en cause, il pourra s'agir de mesures de contrôle, telles qu'exclusion, isolement ou traitement obligatoire; dans d'autres cas, il s'agira de recommandations de mesures d'hygiène, de chimioprophylaxie ou de vaccination à offrir aux contacts. La compilation des MADO, tant au niveau régional que provincial, permet quant à elle de connaître l'état de la situation et d'exercer une surveillance de ces maladies, de façon à intervenir promptement, et à une plus large échelle, en cas d'éclosion ou d'épidémie. La surveillance permet aussi de planifier les programmes de prévention de ces maladies, de même que l'évaluation de ces programmes.

MÉTHODOLOGIE

Ce rapport de surveillance des maladies à déclaration obligatoire (MADO) a été élaboré à partir des données disponibles dans le fichier central MADO géré par le Laboratoire de santé publique (LSPQ) pour le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Le présent rapport concerne plus particulièrement les données relatives aux maladies infectieuses pour la région des Laurentides (région socio-sanitaire 15) pour l'année 1996. Pour fins de comparaison, certaines données des années 1990 à 1995 concernant les Laurentides et le Québec sont aussi présentées, de même que certaines données 1996 se rapportant aux autres régions socio-sanitaires (RSS).

Par convention, les données sont classifiées dans le temps selon la date de réception des déclarations à la Direction de la santé publique et les années correspondent aux années de calendrier (soit du 1er janvier au 31 décembre).

Les dénominateurs utilisés pour le calcul des taux de notre région sont tirés des prévisions populationnelles pour 1996 du MSSS, service des études opérationnelles, lesquelles sont basées sur le recensement fédéral de juin 1991 corrigées pour le sous-dénombrement. Le dénominateur pour la région est alors de 447 027 personnes. Mentionnons que les dénominateurs utilisés par le LSPQ pour générer les taux provinciaux et les taux par RSS sont basés sur le recensement fédéral de juin 1991, mais ne sont pas corrigés pour le sous-dénombrement.

L'analyse des données concernant la région des Laurentides a été effectuée à l'aide du logiciel Epi-Info version 6.04b. Pour ce faire, les données se rapportant aux déclarations de la région des Laurentides ont fait l'objet d'une importation à partir du fichier central du LSPQ. Les variables sélectionnées ont été transférées dans un fichier D-Base, analysé par la suite à l'aide d'Epi-Info. Les graphiques inclus dans ce rapport ont été réalisés à l'aide du logiciel Harvard Graphics version 3.0 pour Windows.

Les données illustrant la situation provinciale en comparaison avec la région des Laurentides proviennent des rapports existant dans le fichier central MADO du LSPQ, section "Librairie". Certaines données provinciales concernant les années antérieures peuvent différer entre le rapport MADO 1996 et les rapports publiés en 1995, 1994 et 1993. Ces différences sont dues aux ajustements survenus en cours d'année dans le fichier central du LSPQ. Les données provinciales présentées dans les tableaux du présent rapport sont extraites du rapport annuel 1996 du LSPQ et sont par conséquent les plus à jour.

LIMITES DE L'ANALYSE

DONNÉES DE SURVEILLANCE

Il importe de rappeler que ce rapport constitue en fait un portrait de la "déclaration" de certaines maladies infectieuses, et non pas une image réelle et fiable de la situation épidémiologique de ces maladies sur notre territoire.

En effet, bien que l'analyse porte sur des maladies dont la déclaration est obligatoire selon la Loi, le lecteur gardera en mémoire que cette déclaration n'est malheureusement pas complète. Plusieurs maladies font l'objet d'une sous-déclaration de la part des médecins, et, parfois, des laboratoires. Cette sous-déclaration n'étant pas toujours du même ordre d'importance (la déclaration d'une maladie pouvant par exemple augmenter si une campagne de sensibilisation est effectuée), l'interprétation des fluctuations dans le nombre des MADO s'en trouve d'autant compliquée. Toutefois on constate que les MADO graves et peu fréquentes (ex.: infections à méningocoque, infections invasives à *Haemophilus influenzae* de type b) sont déclarées presque systématiquement.

Ces problèmes inhérents au système de déclaration rendent donc parfois risquées les comparaisons de l'incidence d'une maladie dans le temps puisque, d'une période à une autre, la sous-déclaration peut avoir atteint une proportion différente, ainsi que dans l'espace puisque, d'une région à une autre, le phénomène de sous-déclaration peut avoir joué différemment.

Une autre mise en garde s'impose quant à la comparaison des taux d'infections d'une sous-région (CLSC) à une autre. En effet, bien que les taux (nombre de cas / population) permettent une meilleure comparaison que les nombres de cas, les taux présentés dans ce rapport n'ont pas été standardisés pour l'âge entre les différentes sous-régions. Il est donc possible que, pour certaines maladies affectant plus particulièrement certains groupes d'âge, les différences observées entre les taux bruts soient en partie attribuables aux différences de la répartition de la population par groupe d'âge entre les sous-régions. Cette mise en garde s'applique aussi aux données 1996 concernant les différentes régions socio-sanitaires. Les graphiques comparant les taux d'incidence de certaines MADO selon la région socio-sanitaire doivent donc être interprétés avec la plus grande prudence, puisque ces taux n'ont pas été standardisés pour l'âge. De plus, ces graphiques comportent une autre possibilité d'erreur d'interprétation, liée à la précision des données utilisées. En effet, les dénominateurs utilisés pour le calcul de ces taux, pour les régions socio-sanitaires autres que les Laurentides, sont basés sur le recensement fédéral de juin 1991 sans être corrigés pour le sous-dénombrement. Pour les Laurentides, le dénominateur utilisé, bien que basé lui aussi sur le recensement fédéral de juin 1991, est corrigé pour le sous-dénombrement. L'utilisation du dénominateur corrigé pour les Laurentides nous apparaissait préférable, en raison de l'accroissement rapide de

notre population. Ces différences de dénominateur n'affectent toutefois pas les taux (et leur comparaison) de façon importante.

Par ailleurs, il faut souligner que dans les régions ou sous-régions où la population est relativement peu nombreuse, lorsque le nombre de cas d'une maladie devient très petit (par exemple moins de 5 par sous-région), la simple survenue d'un cas de plus ou de moins fait varier l'incidence de façon importante. Il faut donc être attentif au nombre de cas observé lorsqu'on compare les taux; c'est pourquoi nous avons ajouté le nombre de cas sur plusieurs graphiques illustrant des taux.

DESCRIPTION DES INTERVENTIONS

En plus de l'analyse des données de déclaration, ce rapport présente, pour les MADO commentées, une brève description des interventions préventives réalisées. Ce portrait est cependant fort sommaire, les interventions relatives aux enquêtes réalisées n'étant pas compilées par le système informatique. La description des interventions reste donc plutôt qualitative ou approximative lorsque des nombres sont proposés.

Par ailleurs, ce rapport ne tient pas compte des interventions effectuées lorsque des MADO sont suspectées ou appréhendées, mais ne s'avèrent pas, après enquête, correspondre aux définitions nécessaires pour être officiellement déclarées. Le présent rapport ne permet donc de dresser qu'un portrait bien incomplet des interventions réalisées dans le cadre du contrôle des maladies infectieuses.

PORTRAIT-SYNTHÈSE
MADO-LAURENTIDES 1996

Le portrait-synthèse qui suit décrit, de manière succincte, les tendances présentées par certaines maladies infectieuses à déclaration obligatoire dans la région des Laurentides en 1996. Il inclut aussi une brève description des interventions entreprises dans le contrôle de certaines maladies infectieuses sur notre territoire. Pour faciliter la compréhension de ce portrait, les maladies infectieuses y ont été regroupées en grandes catégories selon leur mode de transmission. Il s'agit des maladies transmissibles sexuellement et/ou par contact avec du sang contaminé, des maladies transmises par voie respiratoire, des maladies transmises par voie fécale-orale et des maladies reliées aux voyages internationaux. Les graphiques de la section suivante illustrent un certain nombre de MADO, regroupées selon les mêmes catégories. Les tableaux de la dernière section contiennent quant à eux les données concernant toutes les MADO, par ordre alphabétique.

L'examen des graphiques et tableaux présentés dans ce rapport nous permet, dans un premier temps, quelques observations globales (voir graphiques pp. 27 et 28). En 1996, 1208 déclarations ont été reçues à la Direction de la santé publique des Laurentides, pour un taux de déclaration de 270,2 déclarations par 100 000 habitants pour l'année. Ce taux représente une légère baisse par rapport à l'année 1995, alors qu'il était de 327 déclarations par 100 000. Notons que le taux de déclaration pour l'ensemble du Québec était de 292,7 par 100 000 en 1996. Depuis 1990, les taux de déclaration des MADO ont diminué progressivement, tant au Québec que dans les Laurentides. Ce taux était de 446,2 par 100 000 personnes en 1990 dans les Laurentides.

Le taux de déclaration le plus élevé en 1996 a été observé pour le territoire du CLSC des Hautes Laurentides avec 323 cas par 100 000. Le territoire du CLSC des Trois-Vallées présentait quant à lui, comme en 1995, le taux le plus bas avec 196,3 par 100 000 (ce taux était de 149 par 100 000 en 1995).

La diminution du nombre de cas déclarés en 1996 s'est surtout fait sentir au niveau de la coqueluche et, dans une moindre mesure, au niveau de la scarlatine et de la chlamydiose génitale. Par contre, les maladies entériques (campylobactériose, giardiase, hépatite A, salmonellose, yersiniose) ont été déclarées en plus grand nombre en 1996. Les maladies rapportées le plus fréquemment ont été la chlamydiose génitale (380 cas) et la campylobactériose (251 cas), suivies de la salmonellose (119 cas), la giardiase (82 cas), la scarlatine (79 cas) et la coqueluche (76 cas).

Certaines maladies importantes sont demeurées très rares ou absentes. Cinq cas d'infection invasive à méningocoque et 9 cas d'infection invasive à streptocoque bêta-hémolytique du groupe A ont toutefois été déclarés en 1996 dans les Laurentides. Au chapitre des maladies évitables par la vaccination, on a rapporté, outre les cas

de coqueluche et d'hépatite B, 4 cas de rougeole et 5 cas d'oreillons. Par ailleurs, aucun cas d'infection invasive à *Haemophilus influenzae* de type b, de rubéole, de diphtérie, de tétanos et de poliomyélite n'a été signalé.

MALADIES TRANSMISES SEXUELLEMENT ET/OU PAR LE SANG CONTAMINÉ

(voir graphiques pp. 29 à 38)

Certaines MTS à déclaration obligatoire n'ont fait l'objet d'aucune déclaration en 1996 dans les Laurentides. Il s'agit de la syphilis, du chancre mou, du granulome inguinal et de la lymphogranulomatose vénérienne. Par ailleurs, d'autres MTS, telles que les condylomes et l'herpès génital, ne sont pas à déclaration obligatoire et ne seront donc pas abordées dans le cadre de ce rapport.

Chlamydiose génitale

Bien qu'en constante diminution depuis quelques années, la chlamydiose génitale demeurait la MADO la plus fréquemment rapportée en 1996, tout comme au cours des dernières années, et ce tant au Québec que dans les Laurentides. Elle représentait environ le tiers des maladies infectieuses déclarées au Québec et dans les Laurentides en 1996. Dans notre région, elle atteignait un taux de 85 cas par 100 000 personnes-année.

Tel que mentionné dans les rapports MADO précédents, la diminution du nombre de déclarations de chlamydiose reflète probablement, du moins en partie, une réelle diminution du nombre de cas infectés. Toutefois, il est possible que cette diminution soit aussi en partie attribuable à une diminution du nombre de prélèvements de dépistage effectués par les médecins. Par ailleurs, il faut mentionner que le traitement épidémiologique des contacts, c'est-à-dire le traitement d'emblée des partenaires d'une personne présentant un test positif sans qu'ils ne subissent de test de dépistage, est une pratique courante. On peut donc penser que le nombre réel de cas de chlamydiose dans la communauté est probablement supérieur au nombre de cas effectivement déclarés en raison d'un test de dépistage positif.

Quatre-vingt-trois pour cent (83 %) des cas déclarés étaient âgés de 15 à 29 ans en 1996, les taux d'incidence étant les plus élevés chez les 15-19 ans et les 20-24 ans. En 1996 dans les Laurentides, 3,5 fois plus de cas de chlamydiose génitale ont été rapportés chez les femmes que chez les hommes et cette proportion atteignait 11 femmes pour un homme dans le groupe des 15-19 ans. L'hypothèse la plus plausible pour expliquer ce phénomène demeure le fait que les jeunes femmes consultent davantage pour leur contraception et subissent donc plus de tests de dépistage que les hommes. De plus, tel que mentionné précédemment, le traitement des partenaires sans prélèvement est une pratique très courante.

Infection gonococcique génito-urinaire

Dans la région des Laurentides, le taux d'incidence des infections gonococciques génito-urinaires marquait une légère baisse pour atteindre 1,8 cas par 100 000 personnes-année en 1996. Notons qu'il était de 9,5 par 100 000 en 1990. Au Québec, le taux d'incidence de cette infection, bien que plus élevé que dans les Laurentides, décrit une diminution semblable depuis le début des années 90.

En 1996, les infections gonococciques génito-urinaires étaient 16 fois moins fréquentes que les chlamydioses pour l'ensemble du Québec et près de 48 fois moins fréquentes dans les Laurentides. Incidence réellement faible des infections gonococciques, prélèvements effectués moins souvent pour cette infection par rapport à la chlamydiose, difficulté technique à mettre en évidence le gonocoque en raison de sa fragilité, autant d'hypothèses pouvant expliquer, au moins en partie, le faible taux de déclaration des infections gonococciques.

Mentionnons que 6 des 8 cas déclarés en 1996 dans les Laurentides faisaient partie du groupe d'âge des 20 à 39 ans. La répartition des cas selon le sexe était de 7 hommes pour 1 femme en 1996.

En ce qui concerne la résistance aux antibiotiques, aucun des 8 cas d'infection gonococcique déclarés dans les Laurentides en 1996 n'étaient causés par des NGPP (*Neisseria gonorrhoeae* producteur de pénicillinase), alors que 4 des 14 cas signalés en 1995 l'étaient (29%).

Tout comme pour la chlamydiose, les déclarations d'infection gonococcique génito-urinaire ne font pas l'objet d'enquête par les médecins de la Direction de la santé publique. En effet, la recherche des contacts et leur traitement éventuel relèvent de la responsabilité du médecin traitant le cas-index en collaboration avec ce dernier. Notons que la déclaration des infections gonococciques génito-urinaires se fait sur une base anonyme.

Hépatite B aiguë

L'incidence de l'hépatite B aiguë, transmissible également par contact avec du sang contaminé, a diminué lentement au cours des dernières années, passant de 6,4 cas par 100 000 personnes-année en 1990 à 3,8 cas par 100 000 en 1996 pour l'ensemble du Québec. Dans la région des Laurentides, le taux d'incidence est passé de 5,2 par 100 000 en 1990 à 2,5 en 1996, avec des pics en 1991 et 1994.

Les 11 cas déclarés dans les Laurentides en 1996, 6 hommes et 5 femmes, appartenaient au groupe d'âge 30 à 59 ans.

Rappelons que ces données ne concernent que les cas déclarés d'hépatite B aiguë et excluent les porteurs chroniques qui nous ont été signalés. Par ailleurs, il faut aussi mentionner que l'hépatite B aiguë est souvent peu symptomatique. Par conséquent, la sous-déclaration de cette infection est probablement importante.

Chaque déclaration d'hépatite B fait l'objet d'une enquête épidémiologique : appel téléphonique au médecin traitant, enquête téléphonique auprès du cas déclaré (en vue de l'identification de la source de l'infection et de la recherche des contacts), éducation du cas-index et des contacts au sujet des mesures préventives, recommandation de vaccination et d'analyse sérologique des contacts s'il y a lieu. Dans les Laurentides, 61 enquêtes ont été réalisées en 1996, incluant les cas aigus et les porteurs signalés. Cent (100) contacts de personnes infectées ont été vaccinés et/ou ont reçu des immunoglobulines spécifiques contre l'hépatite B suite à ces enquêtes.

Lors d'accidents impliquant du sang potentiellement contaminé, de l'information et des recommandations sont transmises aux personnes concernées. En 1996, 12 personnes ont reçu une immunoprophylaxie (vaccination et/ou immunoglobulines spécifiques contre l'hépatite B) suite à de tels accidents dans les Laurentides. Ceci ne tient pas compte des interventions réalisées en ce sens dans les divers hôpitaux du territoire auprès de leurs employés qui ont eu des accidents de travail impliquant du sang potentiellement contaminé.

Par ailleurs, les interventions de vaccination auprès de groupes-cibles, débutées au cours de l'année 1994, ont été poursuivies en 1996. Dans les Laurentides, le taux de couverture vaccinale obtenu lors de la vaccination systématique des élèves de 4e année primaire par les infirmières des CLSC en 1996 était légèrement inférieur à 85 %.

Sida

Comme en 1995, 20 cas de sida ont été déclarés dans les Laurentides en 1996, pour un taux de 4,5 par 100 000 personnes-année. Pour l'ensemble du Québec, le taux est demeuré stable de 1995 à 1996, à 10,8 par 100 000.

Quant à la distribution selon l'âge, on peut mentionner que tous les cas déclarés dans les Laurentides en 1996 étaient âgés entre 25 et 59 ans. Dix-sept des 20 cas déclarés étaient des hommes.

Il est important de rappeler que seul le sida (correspondant à des critères diagnostiques bien précis) fait l'objet d'une déclaration obligatoire. La séropositivité pour l'infection à VIH (virus de l'immunodéficience humaine) n'est pas à déclaration obligatoire et aucune donnée n'est disponible à ce sujet dans les Laurentides.

Chaque déclaration de sida fait l'objet d'un contact téléphonique auprès du médecin traitant. La déclaration du sida étant anonyme, aucune enquête n'est effectuée auprès du cas déclaré. Toutefois, on vérifie auprès du médecin traitant si la recherche des contacts a été faite et on complète les informations nécessaires aux fins de surveillance de cette infection. Le médecin traitant constitue donc le principal partenaire impliqué dans l'intervention auprès du cas déclaré.

Au chapitre des activités de prévention-promotion, mentionnons que des sessions d'information sur le VIH, le VHB (virus de l'hépatite B), le VHC (virus de l'hépatite C) et les précautions universelles sont réalisées régulièrement dans les CH, les CHLD et les centres de détention des Laurentides.

Par ailleurs, la diffusion, débutée en 1995, du guide sur la conduite à tenir lors d'exposition accidentelle au sang, élaboré à l'intention des établissements du réseau de la santé par l'équipe MTS-sida de la Direction de la santé publique, s'est poursuivie en 1996.

MALADIES TRANSMISES PAR VOIE RESPIRATOIRE

(voir graphiques pp. 39 à 52)

Étant donné que le présent rapport concerne les MADO, certaines maladies transmises par voie aérienne qui ne font pas partie des MADO n'y seront pas discutées, bien qu'elles soient par ailleurs très présentes dans la communauté. Ainsi, on ne doit pas oublier que la grippe, la pneumonie et les diverses autres maladies dues à des virus respiratoires entraînent des interventions de santé publique non négligeables.

Coqueluche

En 1996, on a pu observer une chute importante du nombre de cas déclarés de coqueluche, comme on pouvait s'y attendre en 1995 après un cycle épidémique. Avec 76 cas, dont 24 confirmés par laboratoire, les Laurentides font maintenant partie des régions les moins touchées par la coqueluche (le taux était de 17 cas par 100 000 personnes-année en 1996). Les groupes d'âge les plus affectés sont toujours les 0-4 ans et les 5-9 ans. Aucun décès secondaire à la coqueluche n'a été signalé en 1996 dans les Laurentides.

La distribution des cas de coqueluche reste saisonnière, avec un pic à l'automne.

Tous les cas de coqueluche déclarés entraînent une enquête. La déclaration d'un cas de coqueluche clinique se fait par le médecin traitant tandis que le laboratoire doit déclarer les cas confirmés. Les cas sont aussi signalés au médecin de la Direction de la santé publique par l'infirmière scolaire ou le parent de l'enfant. Une fois le cas validé par un appel aux parents ou au médecin traitant, les recommandations nécessaires sont faites aux contacts, selon la situation (prophylaxie à l'aide d'antibiotiques et/ou vaccination). Le milieu scolaire ou le service de garde sont souvent mis à contribution pour distribuer des lettres d'information aux parents.

Un retard important dans la déclaration des cas de coqueluche est noté : 24 jours en moyenne entre le début des symptômes et la déclaration. Ceci limite l'efficacité de l'intervention.

Scarlatine et infection envahissante à streptocoque du groupe A

Pour la scarlatine, la tendance est également à la baisse. Cependant, cette diminution est moins marquée que pour la coqueluche et les Laurentides présentent un taux d'incidence supérieur à la moyenne québécoise (17,7 cas par 100 000 versus 11,5 cas par 100 000). La distribution des cas est toujours saisonnière (hiver) et la maladie atteint surtout les enfants de moins de 10 ans. Tous les cas déclarés ont été confirmés par un prélèvement de gorge positif pour le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A.

Les écoles et les services de garde sont la principale source de signalement des cas, et leur personnel participe à la distribution de lettres d'information aux parents. Les infirmières des CLSC agissent auprès des écoles et garderies pour transmettre l'information et s'assurer de la mise en place des mesures de contrôle. Les déclarations entraînent une enquête auprès de la famille et du médecin traitant pour confirmer le cas, assurer la surveillance des contacts quant à l'éventualité de l'apparition de cas secondaires afin d'amorcer un traitement précoce. Aucune antibioprophylaxie n'est recommandée aux contacts des cas de scarlatine.

Neuf cas d'infection envahissante à streptocoque du groupe A ont été déclarés en 1996, soit 3 de plus qu'en 1995. Aucun de ces cas n'est décédé, ni n'a subi d'amputation ou de séquelle majeure.

Infection à méningocoque

Cinq cas d'infection à méningocoque ont été déclarés en 1996 dans les Laurentides, dont 4 cas de sérogroupe B et un cas de sérogroupe C, qui ont tous guéri sans séquelles. Le taux d'incidence noté dans les Laurentides est semblable à la moyenne québécoise et cette maladie touche surtout les moins de 5 ans. Le sérogroupe C reste rare depuis la campagne de vaccination provinciale de 1992.

Rougeole

En ce qui concerne la rougeole, seulement 4 cas ont été observés en 1996 dans les Laurentides. Un cas est survenu chez une enfant de 3 ans non vaccinée, alors que les 3 autres étaient reliés à une éclosion dans un milieu collégial d'un autre territoire.

Il faut noter qu'en 1996 une importante campagne de revaccination contre la rougeole s'est déroulée au Québec. Cette campagne, qui a mobilisé grandement les ressources des CLSC, des écoles et de la Direction de la santé publique, visait toute la population scolaire depuis la maternelle jusqu'au secondaire, de même que les enfants de 18 mois à 5 ans. Notons que le niveau collégial n'était pas visé par la campagne de vaccination. Dans les Laurentides, la couverture vaccinale obtenue a été de 88,7% dans les écoles primaires, 85,9% au secondaire, et elle est estimée à 52,2% pour les 18 mois à 5 ans qui représentent une population-cible plus difficile à rejoindre.

Tuberculose

Nous n'avons observé que 3 cas de tuberculose dans les Laurentides en 1996, ce qui représente un taux de 0,7 par 100 000, le plus bas au Québec en 1996. Aucun de ces cas ne présentait de résistance aux antibiotiques. Il s'agissait de 3 hommes âgés respectivement de 22, 45 et 64 ans. Malgré le faible nombre de cas, les activités de contrôle et de surveillance du programme de lutte contre la tuberculose doivent persister pour éviter une recrudescence. Ainsi, des tests à la tuberculine pour le dépistage des cas doivent être faits à tous les contacts des cas, aux stagiaires allant étudier dans les milieux de soins, ainsi qu'aux détenus dans les établissements carcéraux.

Autres maladies évitables par l'immunisation

Cinq cas d'oreillons ont été déclarés, tandis qu'aucun cas d'infection invasive à *Haemophilus influenzae*, de rubéole, de diphtérie, de tétanos, ni de polio n'a été signalé, ce qui confirme l'efficacité des programmes universels d'immunisation.

MALADIES TRANSMISES PAR VOIE FÉCALE-ORALE

(voir graphiques pp. 53 à 70)

Ces infections dans leur ensemble représentent près de la moitié des MADO déclarées dans les Laurentides en 1996. Elles comprennent, par ordre d'importance de survenue, la campylobactériose (251 cas), la salmonellose (119 cas), la giardiase (82 cas), la yersiniose (21 cas), l'entérite à *E.Coli* entéropathogène (14 cas), la shigellose (13 cas) et l'amibiase (6 cas).

La déclaration des maladies entériques entraîne une enquête auprès du cas-index afin d'identifier la source d'infection et d'assurer la protection des contacts, entre autres par l'éducation sur les mesures d'hygiène. Le médecin traitant est sollicité pour le suivi du cas et l'investigation des contacts s'il y a lieu. Lorsqu'une source alimentaire est suspectée, le ministère de l'Alimentation, des Pêcheries et de l'Agriculture du Québec (MAPAQ) effectue les inspections nécessaires. Si une source hydrique est suspectée, le ministère de l'Environnement et de la Faune (MEF) est mis à contribution.

Les maladies entériques sont en grande majorité déclarées par les laboratoires des hôpitaux. En effet, la Loi sur la protection de la santé publique oblige les directeurs de laboratoires à déclarer ces pathogènes. Ainsi toute culture positive pour ces pathogènes fera en principe l'objet d'une déclaration. Le Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ) joue également un rôle dans le typage de certaines souches envoyées par les laboratoires d'hôpitaux, ainsi que dans la déclaration de ces cas.

Éclosions

Dix épisodes de toxi-infection alimentaire reliés à la consommation d'aliments ont été rapportés en 1996, de même qu'une éclosion de diarrhée épidémique. Ces situations ont entraîné des inspections par le MAPAQ. L'impact de ces épisodes se chiffre à plus d'une centaine de malades. D'autres signalements n'ont pas été retenus en raison de l'absence de lien entre les cas.

Campylobactériose

Il s'agit de la MADO entérique la plus déclarée, et la hausse du nombre de cas amorcée en 1994 s'est poursuivie en 1996 avec 251 cas, soit 39 cas de plus qu'en 1995, pour une hausse de 18%.

Avec une distribution des cas typiquement saisonnière (été) et touchant les enfants de moins de 5 ans ainsi que les jeunes adultes (15 à 39 ans), la campylobactériose place les Laurentides au deuxième rang des régions les plus touchées au Québec avec un taux de 56,2 cas déclarés par 100 000 (moyenne québécoise de 40,9 par 100 000). Notons que l'augmentation de cette MADO se manifeste à la grandeur du Québec et du Canada mais qu'on en ignore la cause exacte.

Une enquête postale menée en 1996 par la Direction de la santé publique auprès des cas signalés visait à déterminer si un facteur de risque pouvait expliquer la majorité des épisodes. Les résultats n'ont malheureusement pas permis d'identifier un tel facteur.

Salmonellose

La déclaration de cette maladie entérique poursuit une légère augmentation depuis 1992. Le taux de 26,6 cas déclarés par 100 000 nous situe près de la moyenne Québécoise (23,4). Cette maladie suit une distribution saisonnière (été) et elle touche principalement les enfants de moins de 10 ans. En 1996, elle a augmenté surtout sur les territoires des CLSC Hautes-Laurentides, Argenteuil et Arthur-Buies.

Giardiase

Cette maladie était en forte hausse en 1996, passant de 53 cas à 82 cas, soit une augmentation de 29 cas ou de 55%. L'augmentation du nombre de cas s'est manifestée exclusivement sur le territoire du CLSC Arthur-Buies, où l'incidence est passée de 3 à 40 cas. Les Laurentides dépassent ainsi la moyenne provinciale et sont au 4e rang des régions les plus touchées. Il y aura lieu de surveiller étroitement la situation épidémiologique concernant l'évolution de cette infection sur notre territoire.

Un cycle saisonnier est aussi observable pour la giardiase quoiqu'il soit plus variable que pour les autres maladies entériques. La giardiase touche surtout les enfants de moins de 10 ans.

Entérites à *E.Coli* pathogène et à *Y.enterocolitica*

Alors que la déclaration des entérites à *Escherichia coli* montre une légère tendance à la baisse en 1996 dans les Laurentides, les entérites à *Yersinia enterocolitica* semblent en légère hausse. Les taux de déclaration de ces infections dans les Laurentides s'apparentent aux taux québécois. Ces infections touchent davantage les enfants que les adultes.

En ce qui concerne les maladies entériques, mentionnons finalement que les atteintes dues à des maladies qui ne sont pas incluses dans la liste des MADO font aussi l'objet de mesures de santé publique diverses, sans qu'on puisse toutefois en dresser un portrait précis. On range notamment dans cette catégorie les rotavirus et les virus de type Norwalk.

À noter que l'hépatite A est discutée dans la section sur les maladies reliées aux voyages internationaux.

MALADIES RELIÉES AUX VOYAGES INTERNATIONAUX

En 1996, au moins 37 cas de maladies infectieuses à déclaration obligatoire acquises lors de séjour à l'étranger ont été documentés dans les Laurentides. À l'exception d'un cas de paludisme, il s'agissait toujours d'infections transmises par voie fécale-orale (amibiase, giardiase, hépatite A, salmonellose, shigellose, typhoïde). Ces cas se répartissaient de la manière suivante :

amibiase : 1 des 6 cas était relié, d'après l'enquête épidémiologique, à un séjour au Mexique;
giardiase : 3 cas (sur 82) contractés en Haïti (2 cas) et Cuba (1 cas);
hépatite A : 6 cas (sur 28) survenus suite à des courts séjours au Mexique (1 cas), au Vénézuela (1 cas), en République Dominicaine (1 cas), à Cuba (1 cas), à Ste-Lucie (1 cas) et en Floride (1 cas);
salmonellose : 15 cas reliés à des séjours à l'étranger. Les destinations en cause étaient le Mexique (7 cas), le Maroc (2 cas), les États-Unis (2 cas), Cuba (1 cas), le Sénégal (1 cas), le Gabon (1 cas) et le sud de l'Europe (1 cas);
shigellose : 11 des 13 cas déclarés étaient reliés, d'après l'enquête épidémiologique, à des séjours à l'étranger (Mexique (3), République Dominicaine (2), Cuba (2), Vénézuela, Roumanie, Chine, croisière dans les Caraïbes);
typhoïde : 1 cas relié à un contact avec un voyageur ayant séjourné en Inde.

Il faut toutefois se rappeler que les problèmes de santé reliés aux voyages sont beaucoup plus fréquents, mais ne sont habituellement pas à déclaration obligatoire. La "turista" en est un exemple flagrant : on estime en effet que 20 à 50 % des voyageurs séjournant 2 semaines en pays en développement souffriront de diarrhée. De même, d'autres MADO peuvent avoir été acquises en voyage sans que nous puissions les comptabiliser puisqu'elles ne

font pas l'objet d'une enquête épidémiologique poussée (ex.: les MTS) ou que les personnes atteintes n'ont pu être rejointes lors de l'enquête épidémiologique.

Mentionnons que dans la région des Laurentides, des services préventifs sont offerts aux voyageurs dans 6 CLSC. Ces services comprennent information, consultation pré-voyage et immunisation. En 1995, 3001 voyageurs avaient consulté dans les cliniques santé-voyage de la région. Les immunisations offertes aux voyageurs comprennent, selon les destinations : vaccination de base (diphtérie-tétanos-polio, rougeole-rubéole-oreillons), hépatite A, typhoïde, fièvre jaune, encéphalite japonaise, méningocoque, hépatite B, choléra (voir tableau ci-dessous). À noter que le vaccin contre la fièvre jaune n'est disponible qu'aux cliniques santé-voyage des CLSC Arthur-Buies et Jean-Olivier Chénier.

Nombre de doses de certains vaccins commandés par les cliniques santé-voyage des CLSC de la région des Laurentides, 1996

Produits immunisants	Nombre de doses commandées
Hépatite A (Havrix)	2648
Immunoglobulines	395*
Typhoïde injectable	586
Typhoïde oral	204
Encéphalite japonaise	105
Fièvre jaune	230
Méningocoque	65
Choléra	0

(*) 395 correspond au nombre de ml commandés par les CLSC. La dose d'immunoglobulines pour un adulte est habituellement de 2 ml.

Outre les activités cliniques de consultation en santé-voyage, d'autres activités à visée préventive sont régulièrement réalisées dans ce secteur :

- diffusion d'information aux intervenants de la santé, à la population et aux agents de voyage;
- réunions périodiques des médecins des cliniques santé-voyage de la région;
- sessions régulières de formation du personnel infirmier des CLSC sur la vaccination des voyageurs.

Hépatite A (voir graphiques pp. 71 et 72)

En 1996, 28 cas d'hépatite A ont été déclarés dans les Laurentides (taux d'incidence de 6,3 cas par 100 000 personnes-année), ce qui représente une augmentation de près du triple par rapport au taux d'incidence de 1994. En 1996, le taux d'incidence d'hépatite A déclarée était de 8,5 cas par 100 000 pour l'ensemble du Québec et de 20,3 par 100 000 pour Montréal-Centre.

La distribution des cas déclarés en 1996 dans notre région était assez homogène d'un groupe d'âge à l'autre et selon le sexe (13 hommes / 15 femmes). Chez 6 des 28 cas d'hépatite A déclarés dans les Laurentides, on pouvait relier l'acquisition de l'infection à un séjour à l'étranger.

Rappelons que l'hépatite A peut passer inaperçue, particulièrement chez les jeunes enfants chez qui l'infection est souvent peu ou pas symptomatique. L'hépatite A est par conséquent souvent sous-diagnostiquée. De plus, il existe un phénomène de sous-déclaration difficile à évaluer. Ceci laisse à penser que le nombre relativement peu élevé de cas déclarés ne correspond probablement pas à la situation réelle de cette infection sur notre territoire.

Chaque déclaration d'hépatite A fait l'objet d'une enquête épidémiologique afin d'identifier la source de l'infection et d'en prévenir la transmission. Il s'agit la plupart du temps d'une enquête téléphonique réalisée auprès du médecin traitant et du cas-index. De l'information sur les mesures d'hygiène est transmise au cas-index et, s'il y a lieu, des immunoglobulines sont administrées aux contacts étroits. En 1996, 89 contacts de cas d'hépatite A ont reçu des immunoglobulines dans les Laurentides.

De l'information est transmise aux voyageurs sur les moyens de prévention de l'hépatite A lors des consultations dans les cliniques santé-voyage des CLSC du territoire. La vaccination contre l'hépatite A (*Havrix* ou *VAQTA*) est administrée au voyageur, lorsqu'indiquée.

LA RAGE

(voir graphique p. 74)

Le dernier cas de rage humaine au Québec remonte à 1966. Cependant, des déclarations de morsures animales sur des humains, suivies d'interventions de contrôle et de prophylaxie, sont régulièrement effectuées dans les Laurentides.

Chaque cas de morsure animale entraîne une enquête en vue d'évaluer le risque de contamination rabique. La collaboration est étroite avec les vétérinaires d'Agriculture Canada pour toute évaluation d'animal suspect de rage.

S'il y a lieu, une vaccination antirabique est commencée, en général à l'urgence du centre hospitalier où le patient a consulté, et poursuivie au même centre ou par le médecin du patient.

En 1996, 88 enquêtes concernant des morsures ont été effectuées dans les Laurentides. Quinze d'entre elles ont nécessité la vaccination du patient.

Le pic d'activité de la rage chez les animaux sauvages dans les Laurentides s'est produit en 1992, avec diminution marquée depuis 1993. En 1996, aucun animal n'a été démontré rabique sur notre territoire.

DISCUSSION ET RECOMMANDATIONS

DÉCLARATION ET DIFFUSION DE L'INFORMATION

Rappelons que le présent rapport dresse le portait de la déclaration, et non l'image réelle de l'incidence des maladies infectieuses dans notre région. Plusieurs maladies infectieuses font certainement l'objet d'une sous-déclaration. Toutefois, la sous-déclaration demeure un phénomène difficile à évaluer, phénomène lui-même influencé par différents facteurs tels qu'une modification dans la fréquence de consultation, ou dans le processus diagnostique même (par exemple, si les médecins disposent de meilleurs tests diagnostiques, ou s'ils sont davantage portés à effectuer certains tests diagnostiques en raison d'une campagne de sensibilisation). Par ailleurs, même lorsqu'une personne atteinte d'une maladie infectieuse à déclaration obligatoire consulte et que son infection est diagnostiquée, il est possible que cette infection ne soit pas déclarée par le médecin. Diverses raisons sont alors invoquées pour justifier cet oubli de déclaration :

- l'ignorance de l'obligation légale de déclarer;
- la méconnaissance du mécanisme de déclaration;
- la conviction que "de toute façon le laboratoire va déclarer", ou que "cela ne sert à rien";
- la résistance à l'ingérence possible d'autres intervenants dans la relation médecin-patient;
- la réticence à dévoiler à un tiers des informations jugées confidentielles;
- le manque de temps ou d'intérêt.

La diffusion aux déclarants de l'information relative aux données recueillies par un système de surveillance doit faire partie intégrante d'un tel système. Cette rétro-information aux médecins et aux laboratoires constitue un élément essentiel sur lequel s'appuient les recommandations et les interventions de santé publique. De plus, la rétro-information favorise le maintien ou l'amélioration du processus de déclaration en démontrant aux déclarants l'utilité de leur contribution au système de surveillance.

Dans les Laurentides, depuis décembre 1993, le bulletin de santé publique ***Les maux qui courent*** (produit grâce à l'appui financier de la compagnie pharmaceutique Glaxo) est le véhicule d'information utilisé pour transmettre aux médecins du territoire les données épidémiologiques concernant les maladies infectieuses, ainsi que les recommandations sur les interventions de santé publique. Par ailleurs, en 1996, un aide-mémoire illustrant la liste des MADO a été acheminé à chaque médecin oeuvrant sur notre territoire, ainsi que dans les établissements du réseau de la santé.

Toujours au chapitre de la diffusion de l'information recueillie par la surveillance et des recommandations visant la prévention des maladies infectieuses, mentionnons que la publication du bulletin de santé publique ***Bobos, microbes ... et cie !*** a été poursuivie en 1996 dans les Laurentides. Produit grâce à l'appui financier des pharmacies Brunet de la région des Laurentides, ce bulletin est destiné aux parents d'enfants fréquentant un service de garde et au personnel oeuvrant dans ces services. Dans la région des Laurentides, pour l'année 1995-1996, 3766 places étaient offertes dans les services de garde régis par l'Office des services de garde à l'enfance (2676 dans 53 garderies et 1090 dans 8 agences de garde en milieu familial).

Signalons qu'un bulletin d'information de santé publique destiné aux agents de voyage devrait être publié par la Direction de la santé publique des Laurentides à partir de l'automne 1997, en collaboration avec les Directions de santé publique de Lanaudière et de Mauricie-Bois-Francs, et ce, grâce à l'appui financier de la compagnie pharmaceutique Merck Frosst.

TENDANCES

En supposant le taux de déclaration assez constant, on peut observer les tendances des maladies dans le temps. Certaines fluctuations dans les nombres de cas sont dues au hasard tandis que d'autres sont le fruit de la tendance de la maladie à augmenter ou décroître avec le temps. On peut certainement attribuer à la vaccination la nette diminution des infections à *Haemophilus influenzae* de type b et des infections à méningocoque. ***De façon générale, les maladies infectieuses ont eu tendance à diminuer et on peut attribuer cette tendance, au moins en partie, à la surveillance de la salubrité de notre milieu, à une bonne couverture vaccinale chez les individus et aux activités de contrôle lors de la survenue de cas.***

Cependant la hausse, au cours des dernières années, de la déclaration des maladies infectieuses transmises par voie fécale-orale est préoccupante. Un phénomène artéfactuel devra être éliminé et, s'il y a lieu, une investigation plus poussée sera réalisée.

ÉCLOSIONS

Signalons à ce chapitre que de fréquentes éclosions ponctuelles de maladies entériques sont signalées durant la saison estivale, par exemple dans les camps de vacances. Elles ne font toutefois pas toujours faire l'objet d'une déclaration officielle dans le système en raison de l'absence de diagnostic précis ou d'enquête formelle, d'autant que les mesures de contrôle habituelles ont rapidement résorbé le problème.

Les épisodes d'éclosions mettent en évidence l'importance de la déclaration rapide des maladies transmissibles.

MTS-SIDA

Le commentaire que nous formulions dans les rapports MADO précédents demeure valable, à savoir que la diminution régulière de la déclaration des MTS telles la gonorrhée, la syphilis et la chlamydiose ne doit pas être interprétée trop hâtivement. Il est certain que cette tendance est constante depuis quelques années, en particulier pour la chlamydiose, mais les cliniciens consultés ne croient pas tous que cela corresponde à la réalité. En effet leur impression est plutôt que l'incidence est constante, ou même en légère augmentation. La diminution observée dans la déclaration pourrait être la conséquence d'un changement graduel dans la pratique médicale, alors que les médecins seraient davantage portés à traiter sur une base clinique, sans effectuer de prélèvements. Ainsi les laboratoires déclareraient moins de cas de chlamydiose sans que cela ne reflète la réalité épidémiologique de l'infection.

En ce qui concerne l'hépatite B et le sida, leur situation épidémiologique demeure difficile à évaluer, compte tenu de la sous-déclaration probablement importante dont ces infections font l'objet. Chez les cas de sida, il semble que la toxicomanie constitue un facteur de risque de plus en plus important dans les Laurentides. Quant à l'hépatite B, la vaccination des enfants de 4e année scolaire devrait entraîner à long terme une réduction de cette maladie.

RECOMMANDATIONS

Suite aux constatations faites dans ce rapport, les quelques recommandations suivantes nous semblent pertinentes.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

- Que la déclaration des MADO par les médecins cliniciens continue d'être encouragée de façon persistante en:
  - continuant la publication du bulletin de santé publique *Les maux qui courent*;
  - mettant en place une procédure visant l'envoi aux déclarants d'un compte rendu personnalisé annuel.

- Que la lutte contre les maladies transmissibles, incluant les MTS-sida, soit soutenue et supportée en vue de la protection de la santé publique, particulièrement dans l'élaboration du *Plan d'action de santé publique* en favorisant :

- l'immunisation complète et adéquate des enfants du territoire;
- les interventions de protection de la santé lors de déclaration de cas de maladies infectieuses;
- l'investigation complète et adéquate des éclosions de maladies transmissibles lorsqu'elles surviennent;
- les activités de promotion-prévention relatives à ces maladies;
- la collaboration entre les différents intervenants impliqués.

RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES

- Examen attentif de la situation de la campylobactériose dans les territoires des CLSC du sud des Laurentides et de la giardiase dans le territoire du CLSC Arthur Buies.

- Amélioration du processus de déclaration des épisodes de toxi-infections alimentaires et de diarrhée épidémique dans le système MADO.

- Renforcement des activités de prévention des MTS et du sida.

- Maintien du soutien de l'expertise de la santé publique aux cliniques santé-voyage du territoire.

CONCLUSION

Le présent rapport dresse le bilan des déclarations de MADO infectieuses pour les Laurentides en 1996, en regard des années antérieures, en comparaison avec le Québec, et, dans notre région, par territoire de CLSC, par mois et par âge et sexe. Ces données sont dépendantes de l'incidence réelle des maladies mais aussi du taux de leur déclaration.

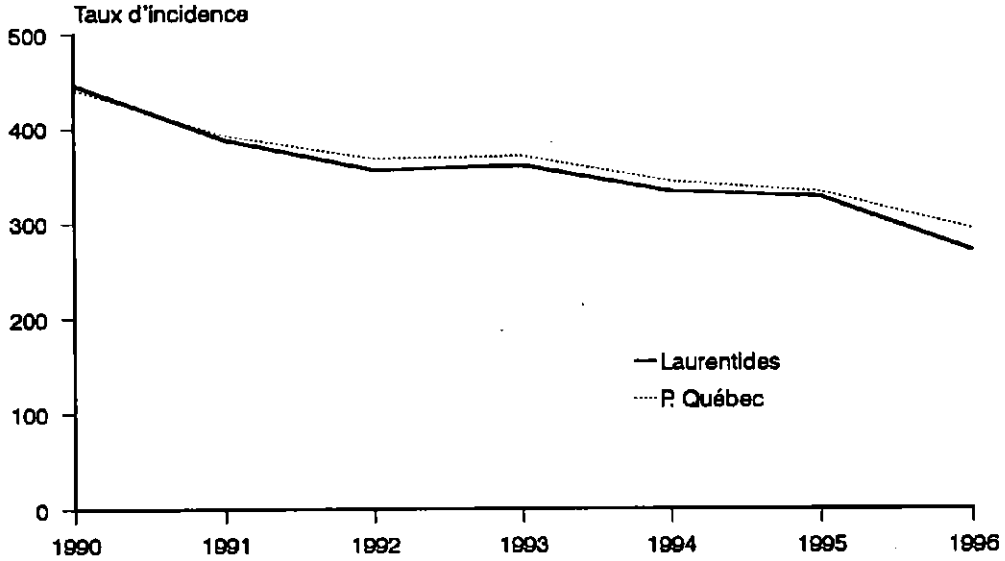
Comme par les années passées, ce rapport décrit succinctement, à la lumière des données de déclaration, la situation épidémiologique de certaines maladies infectieuses d'intérêt dans les Laurentides. Suivent une brève discussion des résultats, ainsi que des recommandations générales et particulières. Les données concernant un certain nombre de MADO sont illustrées sous forme graphique. Le rapport présente aussi, sous forme de tableaux, l'ensemble des données de déclarations pour les Laurentides.

Soulignons enfin que, malgré le fait qu'en général les MADO tendent à diminuer, leur surveillance par leur déclaration obligatoire demeure un outil essentiel à la fois pour connaître l'état de la situation, pour en analyser les tendances et pour intervenir lors d'éclosions. Le partage de ces informations avec les déclarants assurera la persistance d'une bonne déclaration.

GRAPHIQUES ILLUSTRANT CERTAINES MADO

Maladies infectieuses à déclaration obligatoire

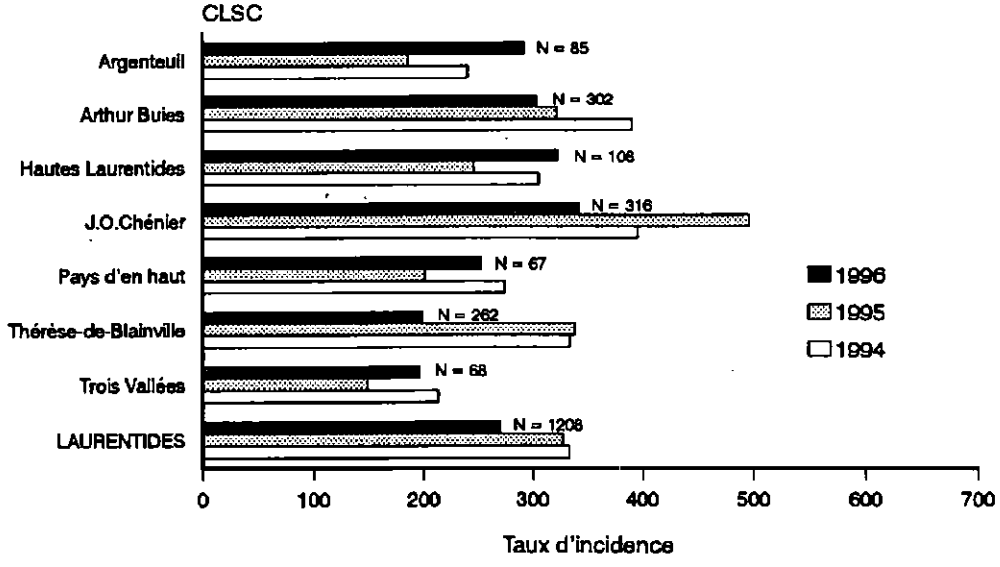
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
Laurentides et P. Québec, 1990-1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

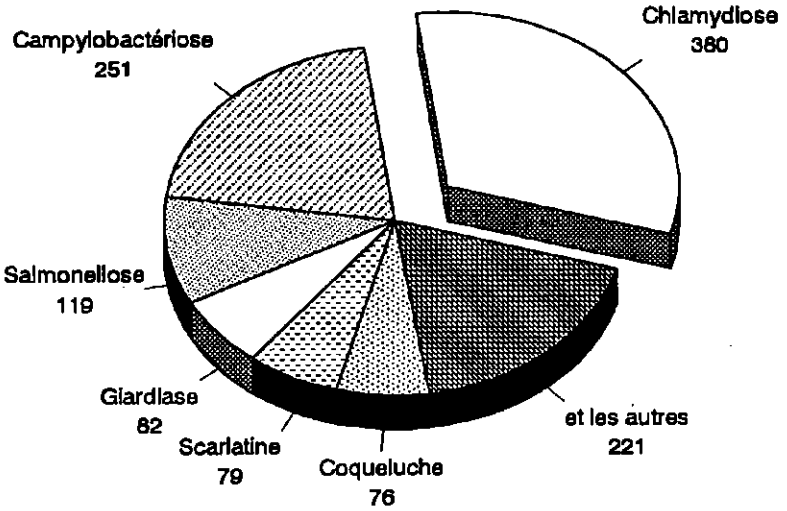
Maladies infectieuses à déclaration obligatoire

Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
par CLSC, Laurentides, 1994-1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Répartition des déclarations
selon les maladies infectieuses
Laurentides, 1996



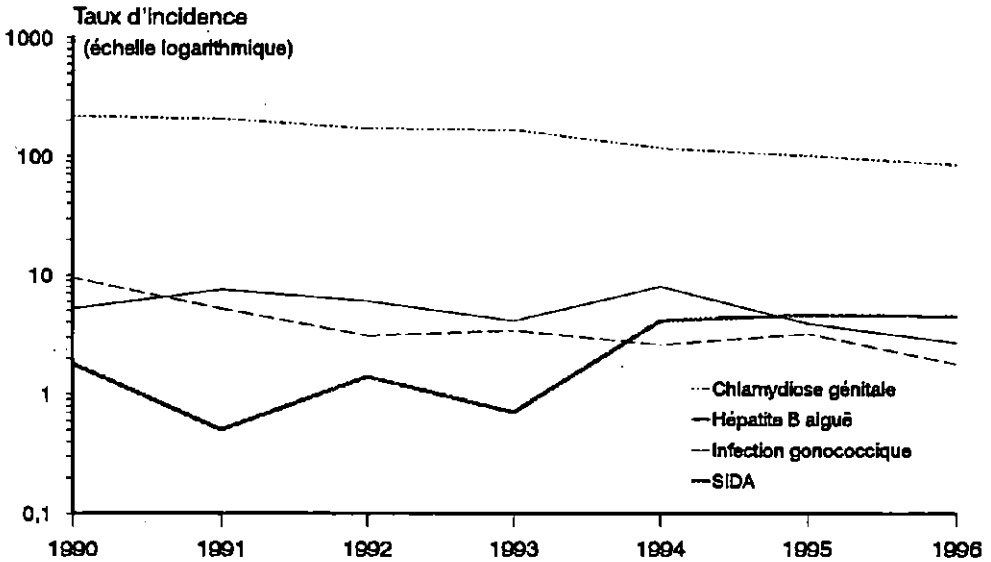
Nombre total de maladies infectieuses déclarées : 1208

Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

MALADIES TRANSMISES SEXUELLEMENT ET/OU PAR LE SANG CONTAMINÉ : CHLAMYDIOSE, INFECTION GONOCOCCIQUE, HÉPATITE B, SIDA

Maladies transmises sexuellement

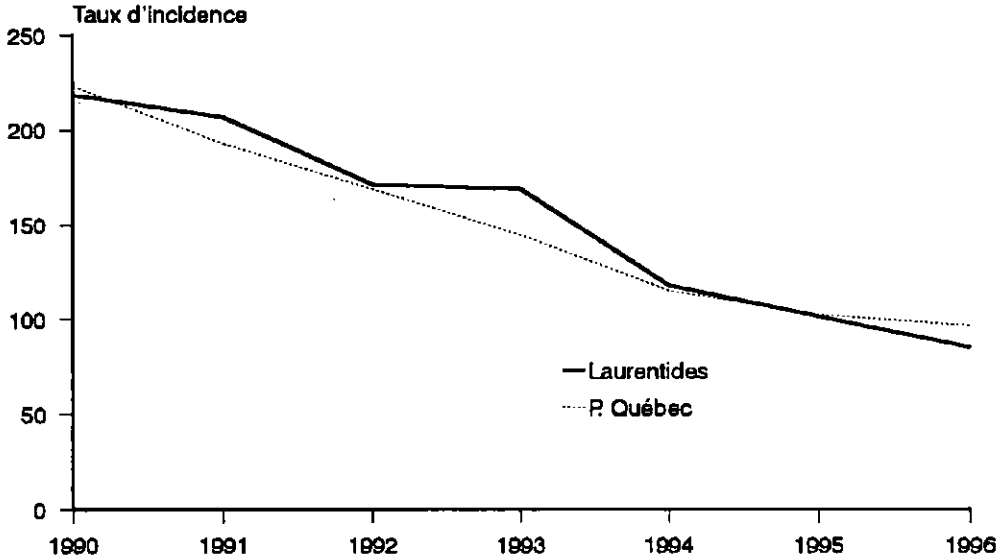
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
Laurentides, 1990-1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Chlamydiose génitale

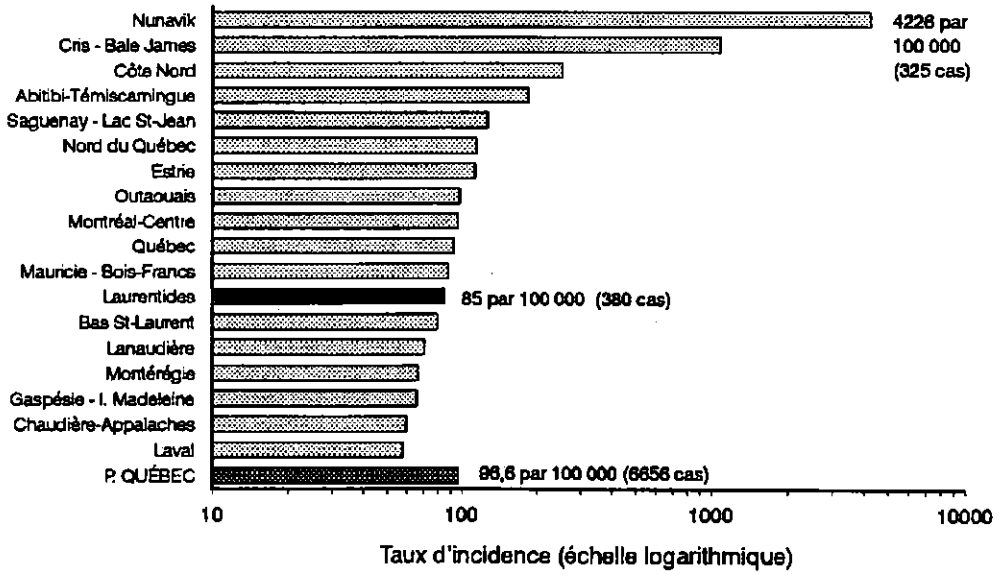
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
Laurentides et P. Québec, 1990-1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Chlamydiose génitale

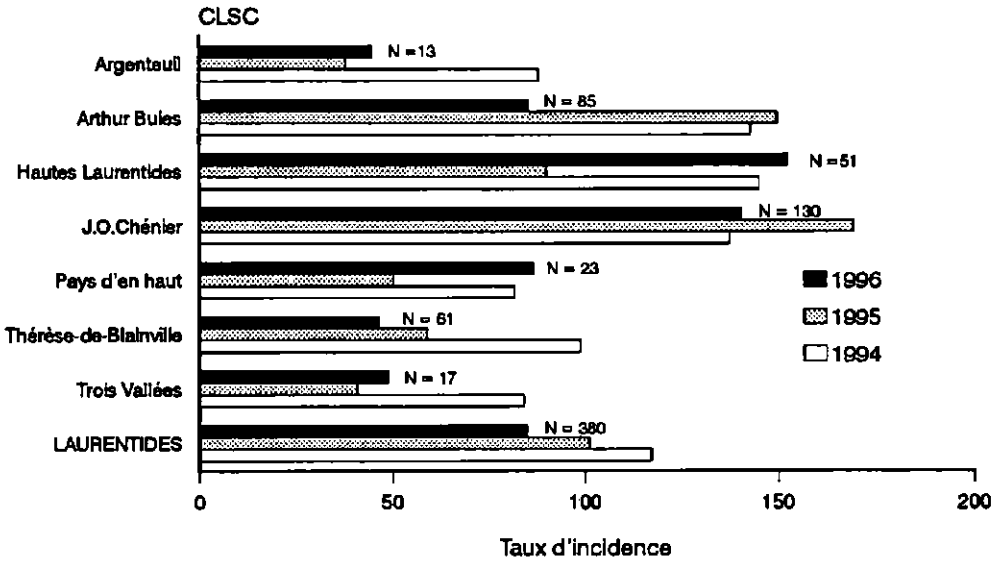
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
par RSS, 1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Chlamydiose génitale

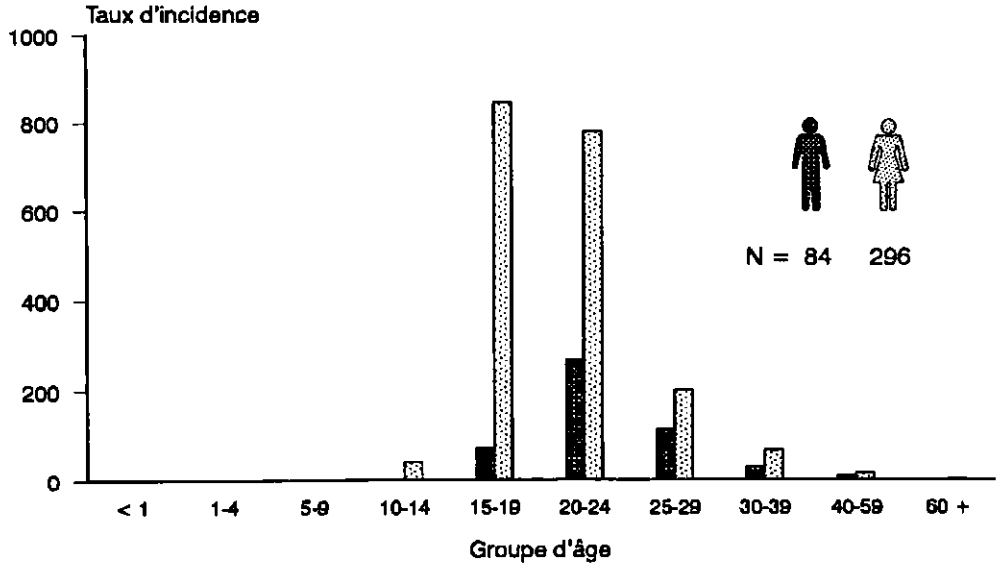
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
par CLSC, Laurentides, 1994-1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Chlamydiose génitale

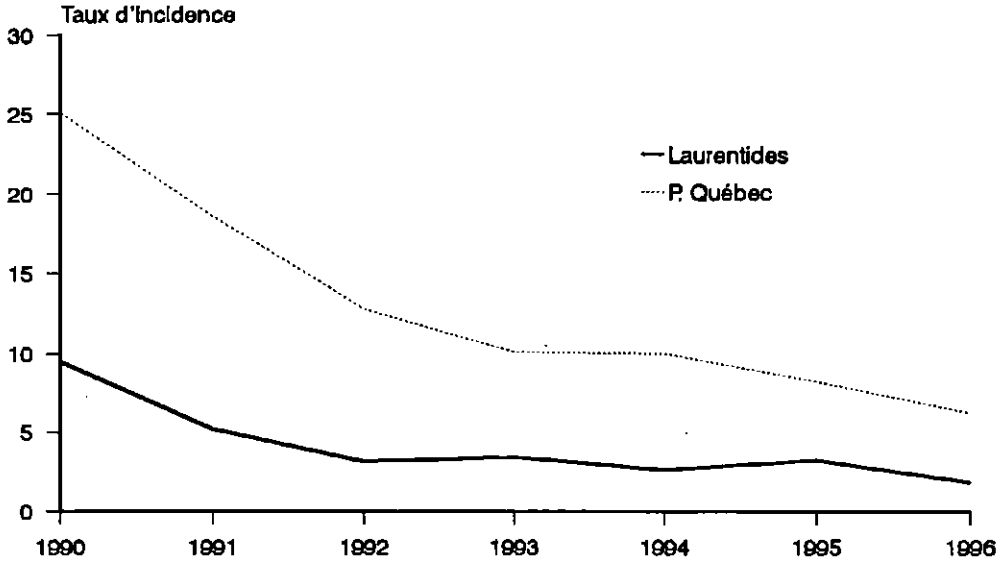
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
par groupe d'âge et sexe, Laurentides, 1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Infection gonococcique génito-urinaire

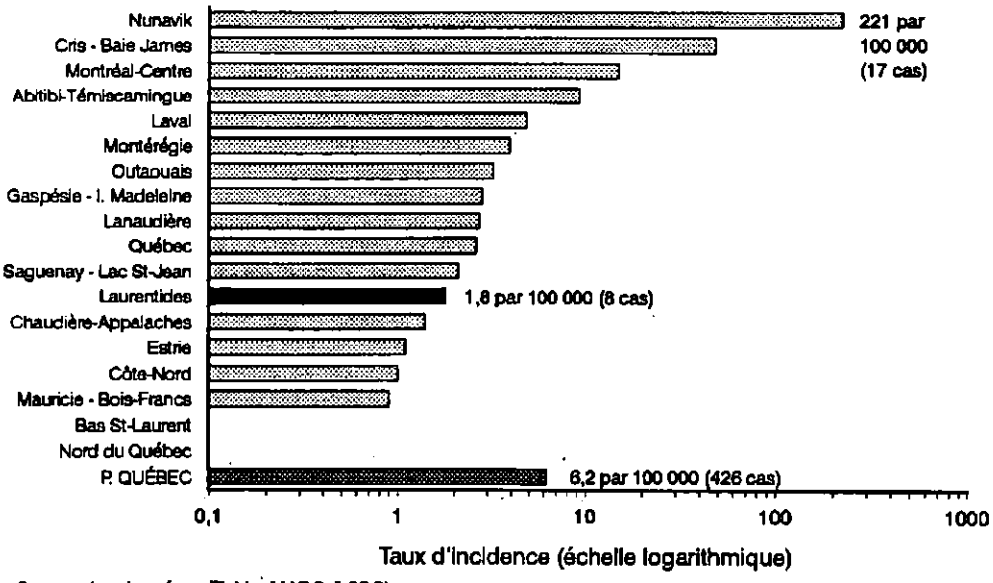
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
Laurentides et P. Québec, 1990-1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

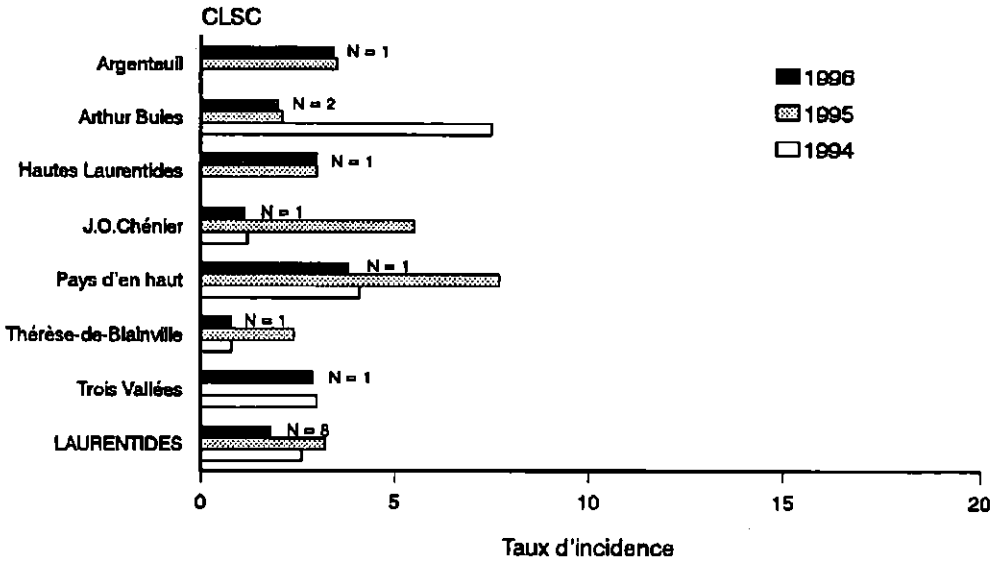
Infection gonococcique génito-urinaire

Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
par RSS, 1996



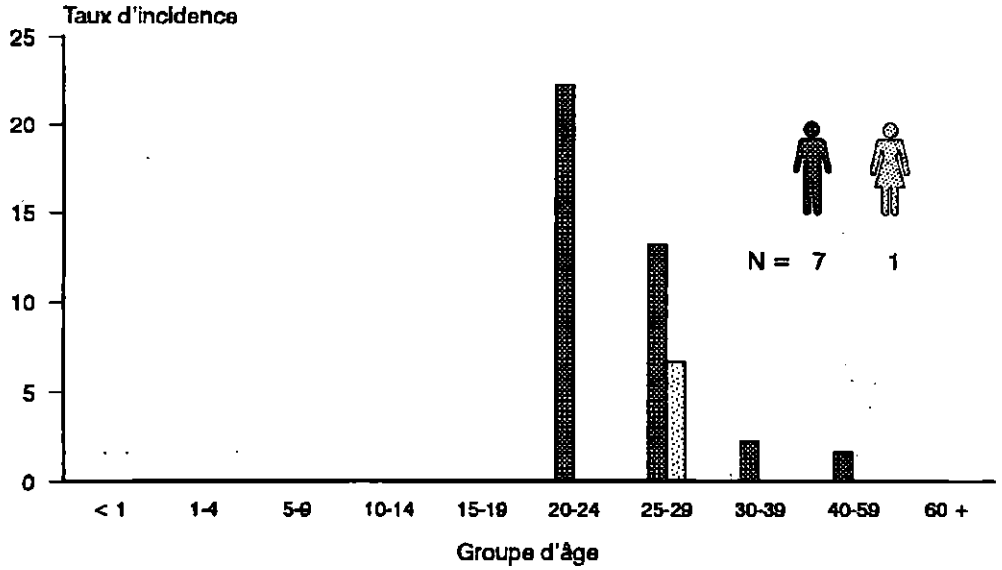
Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Infection gonococcique génito-urinaire
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
par CLSC, Laurentides, 1994-1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

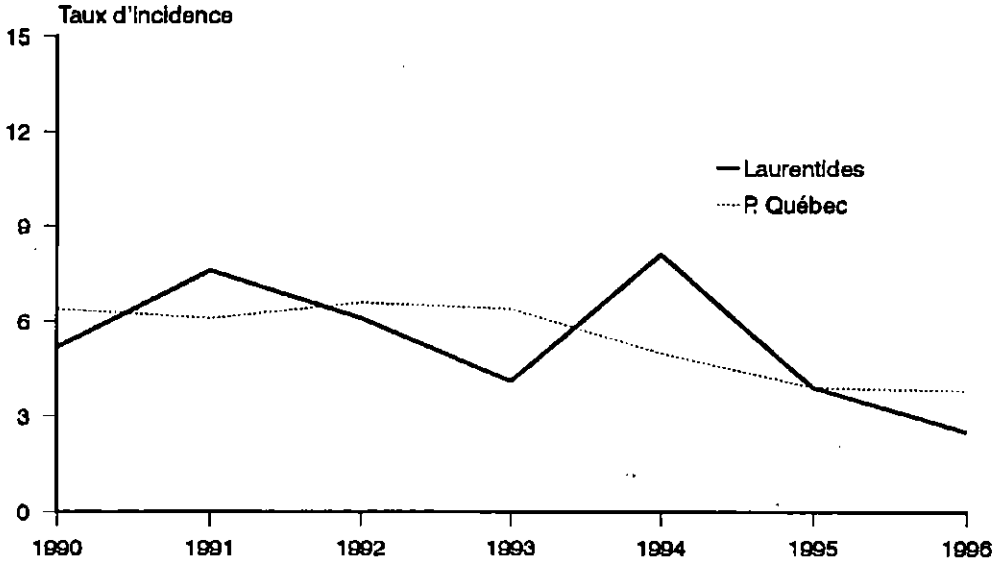
Infection gonococcique génito-urinaire
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
par groupe d'âge et sexe, Laurentides, 1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Hépatite B aiguë

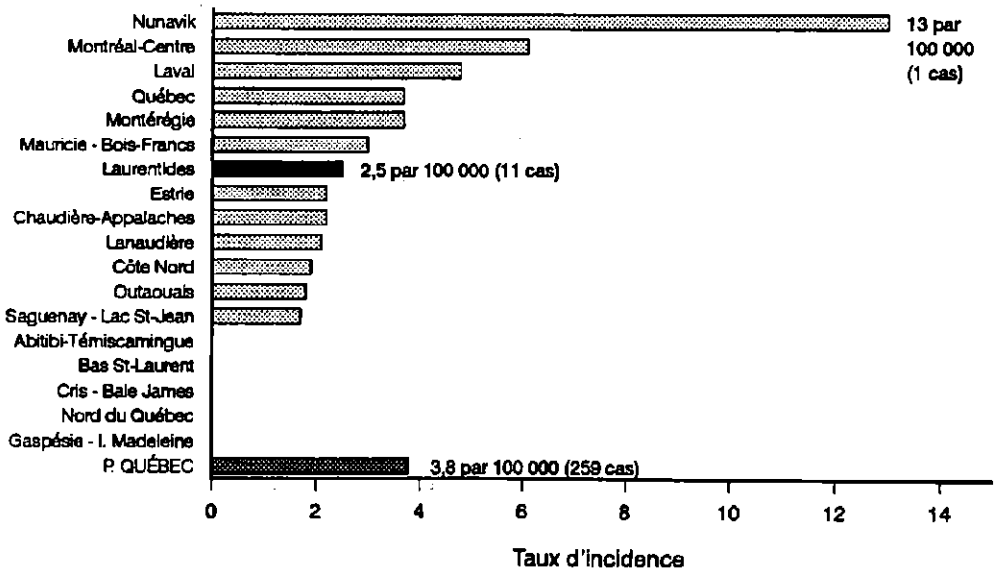
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
Laurentides et P. Québec, 1990-1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Hépatite B aiguë

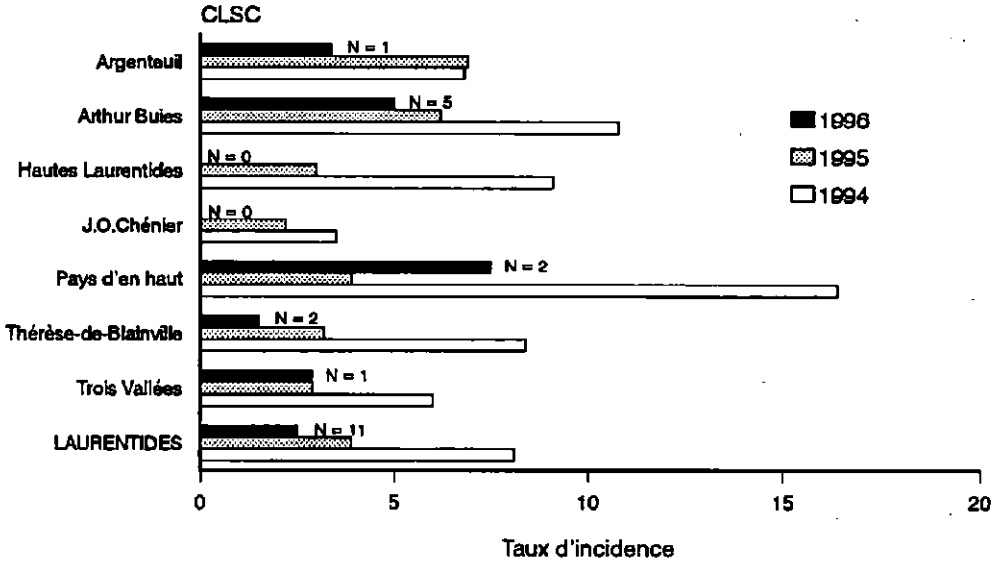
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
par RSS, 1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Hépatite B aiguë

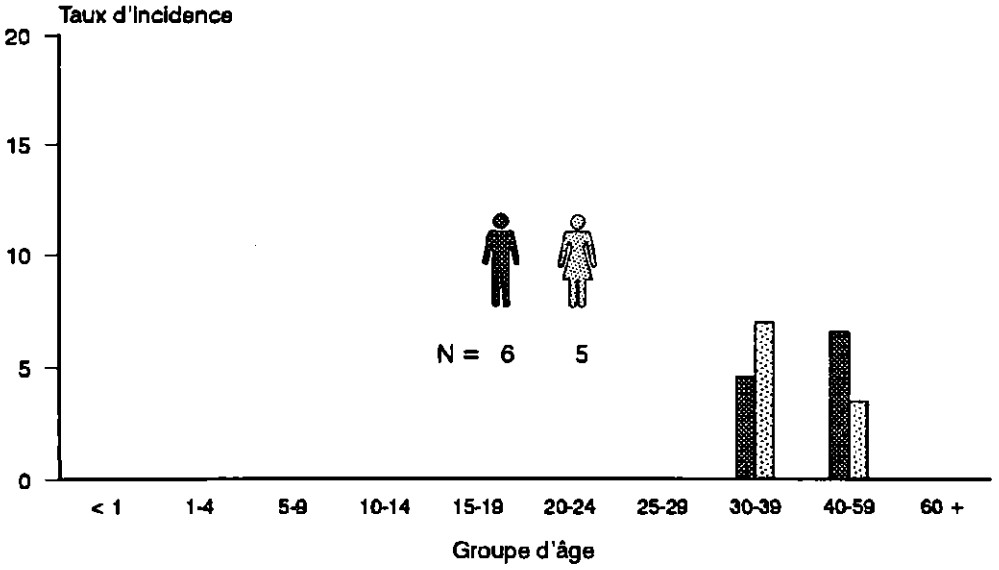
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
par CLSC, Laurentides, 1994-1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Hépatite B aiguë

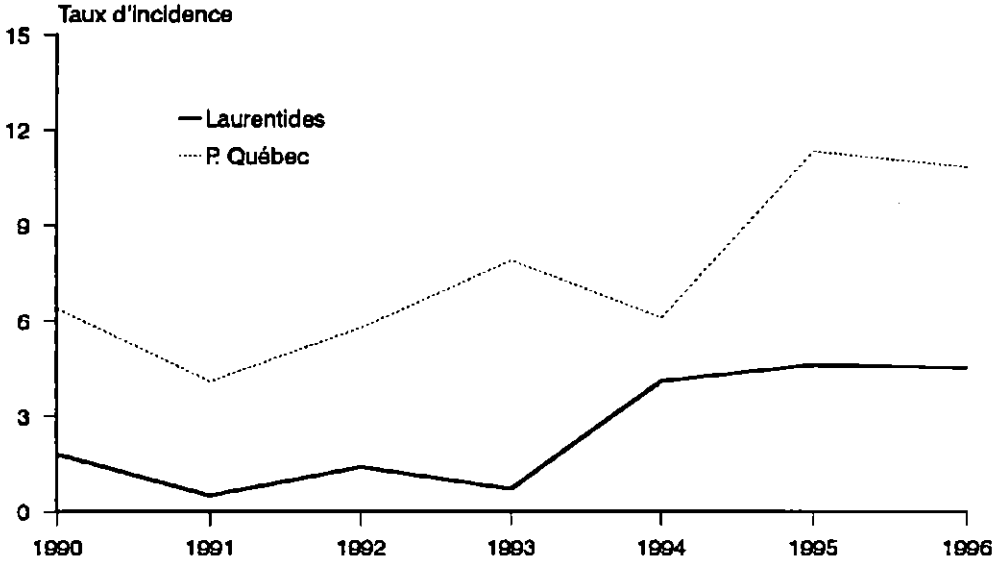
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
par groupe d'âge et sexe, Laurentides, 1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

SIDA

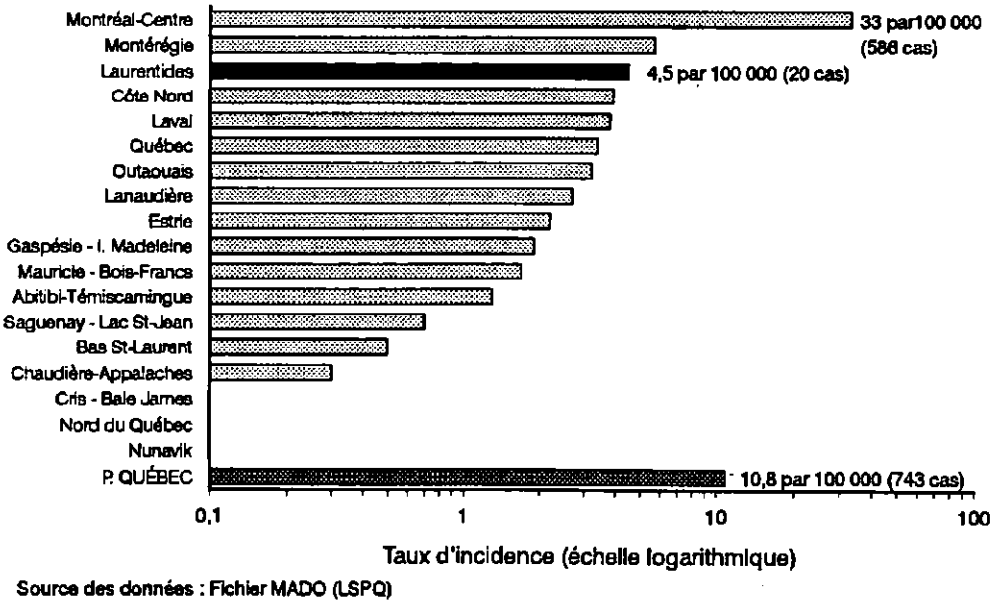
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
Laurentides et P. Québec, 1990-1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

SIDA

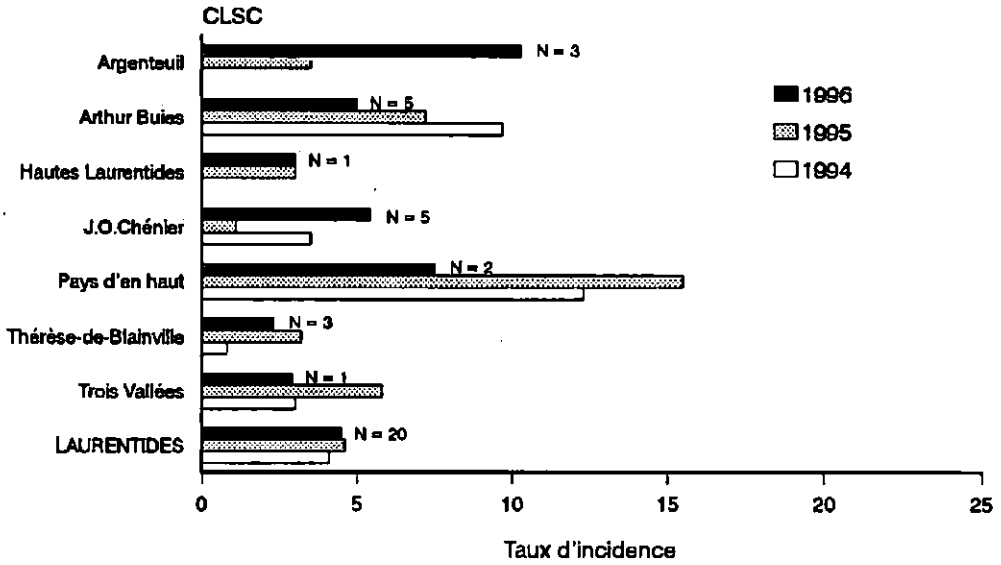
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
par RSS, 1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

SIDA

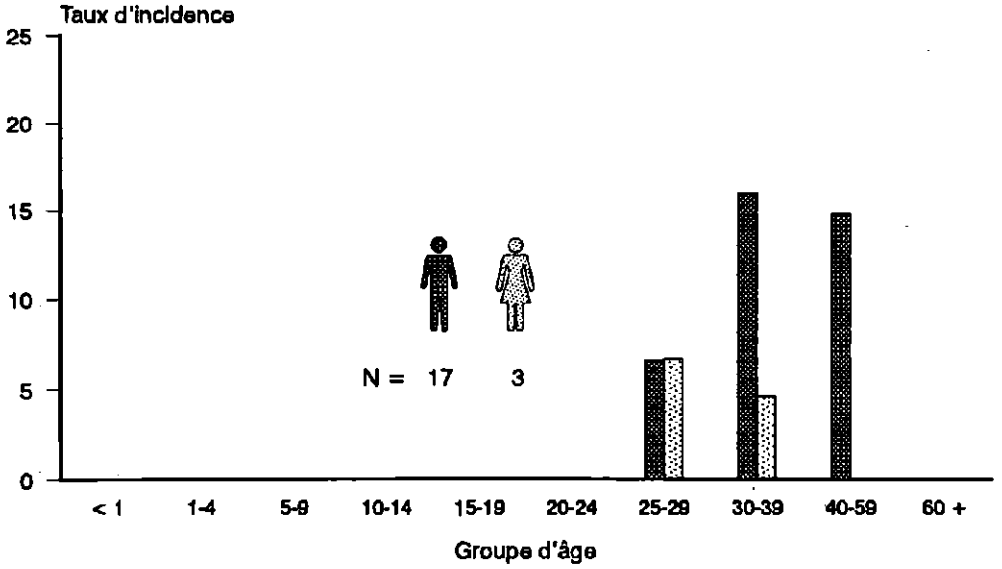
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
par CLSC, Laurentides, 1994-1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

SIDA

Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
par groupe d'âge et sexe, Laurentides, 1996

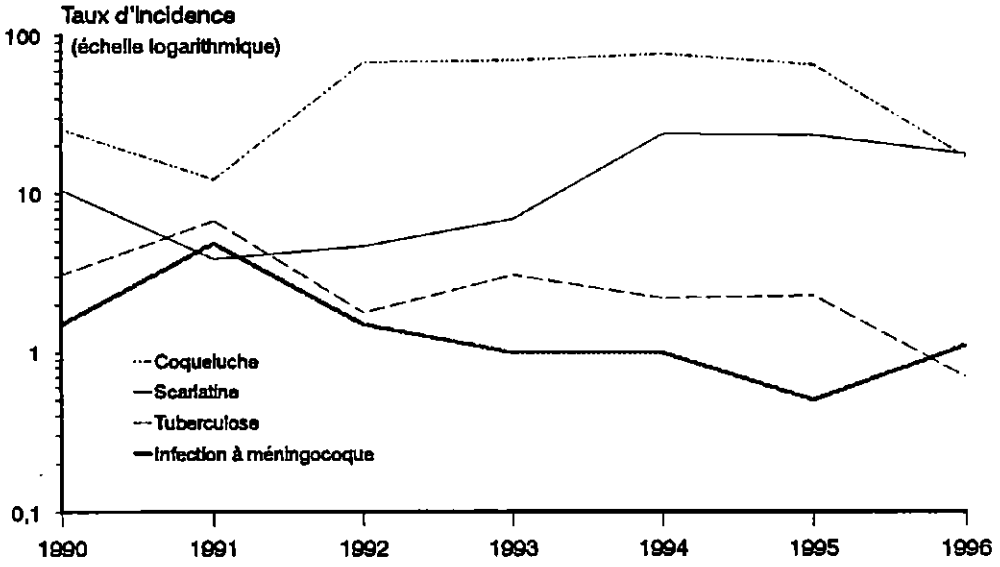


Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

MALADIES TRANSMISES PAR VOIE RESPIRATOIRE : COQUELUCHE, SCARLATINE, INFECTION À MÉNINGOCOQUE, ROUGEOLE, TUBERCULOSE

Maladies transmises par voie respiratoire

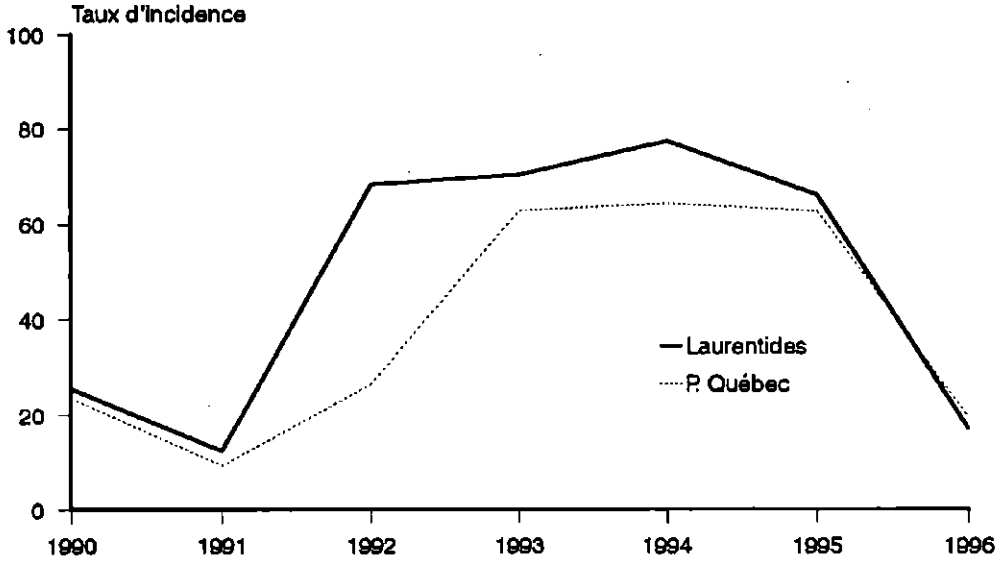
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
Laurentides, 1990-1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Coqueluche

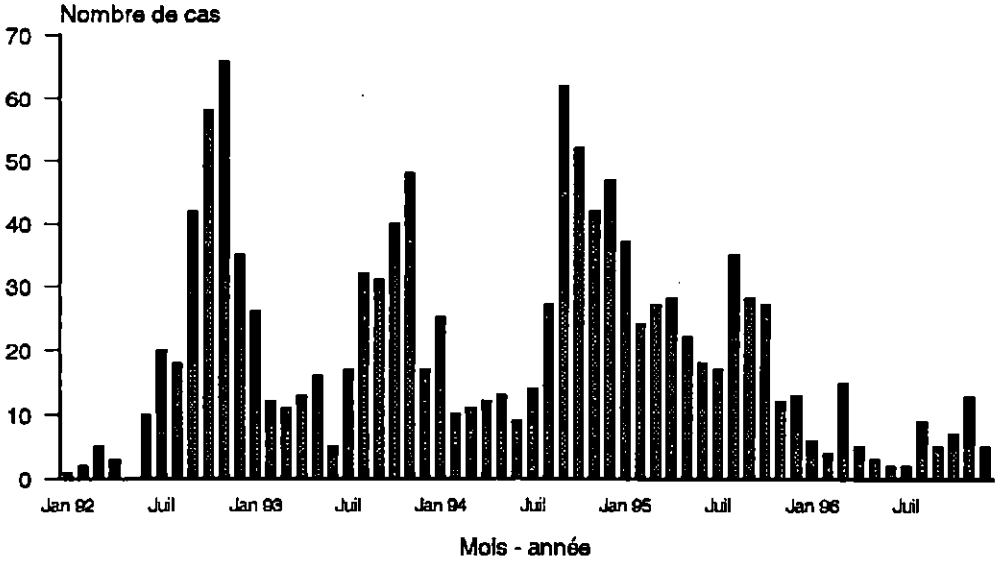
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
Laurentides et P. Québec, 1990-1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Coqueluche

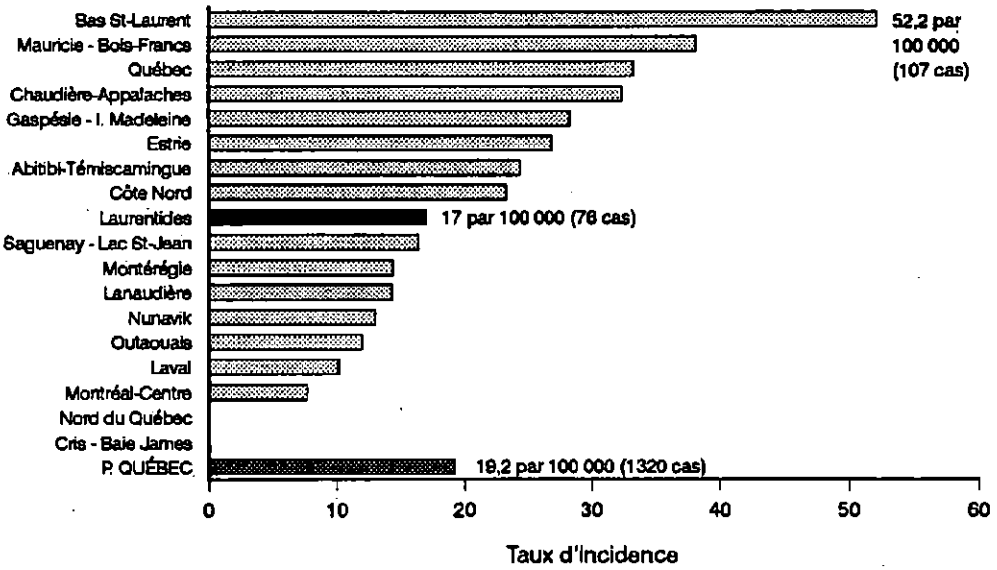
Nombre de cas déclarés par mois
Laurentides, 1992-1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Coqueluche

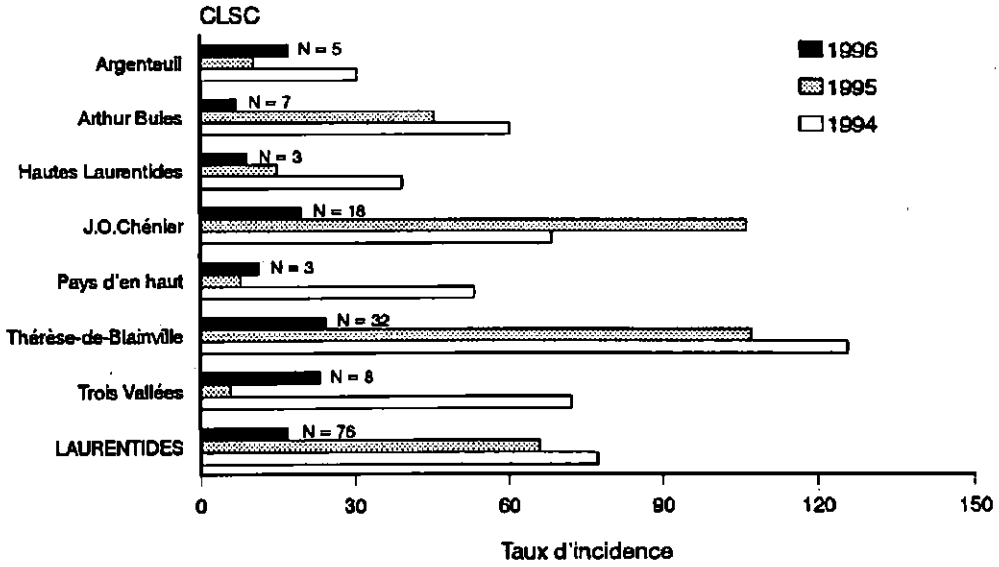
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
par RSS, 1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Coqueluche

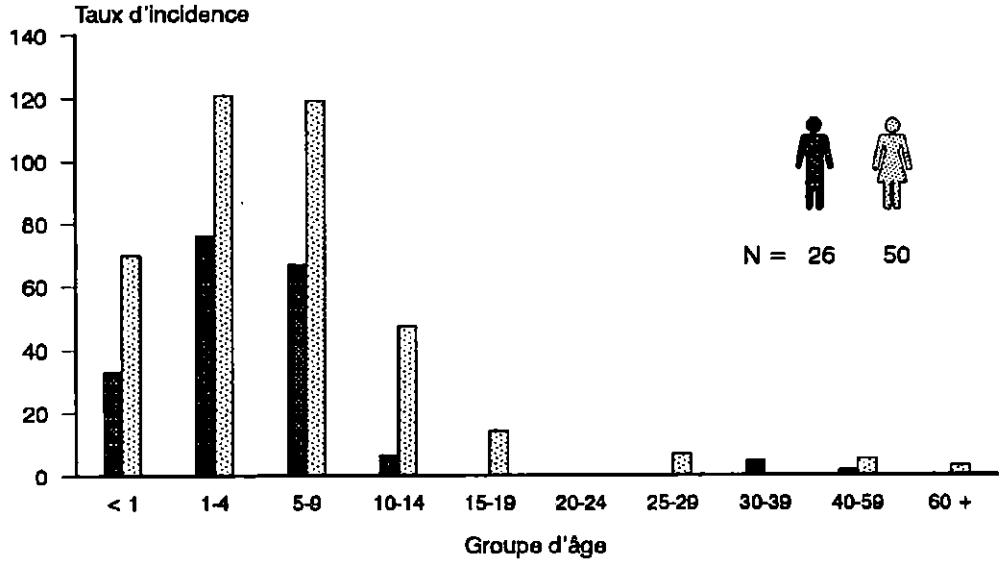
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
par CLSC, Laurentides, 1994-1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Coqueluche

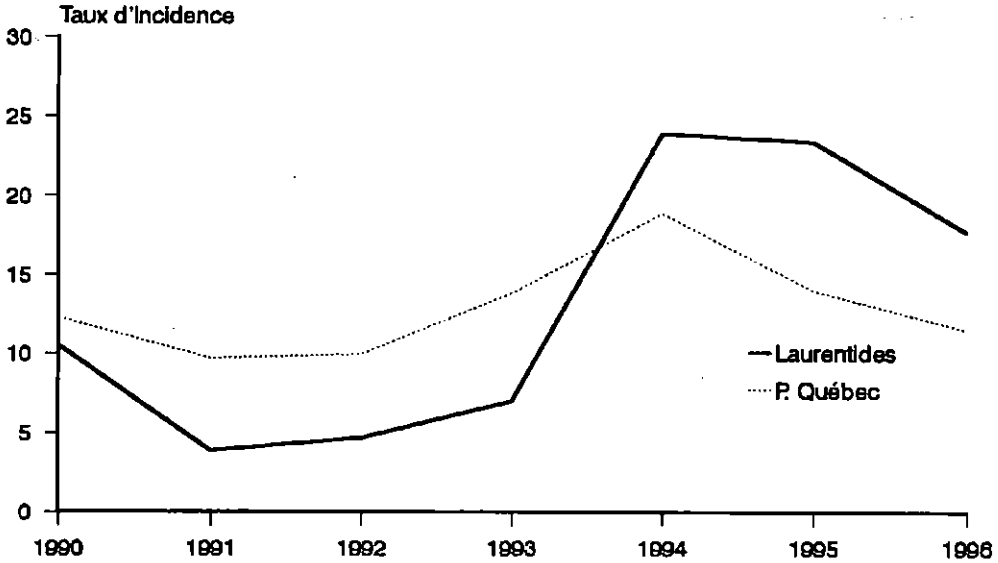
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année par groupe d'âge et sexe, Laurentides, 1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Scarlatine

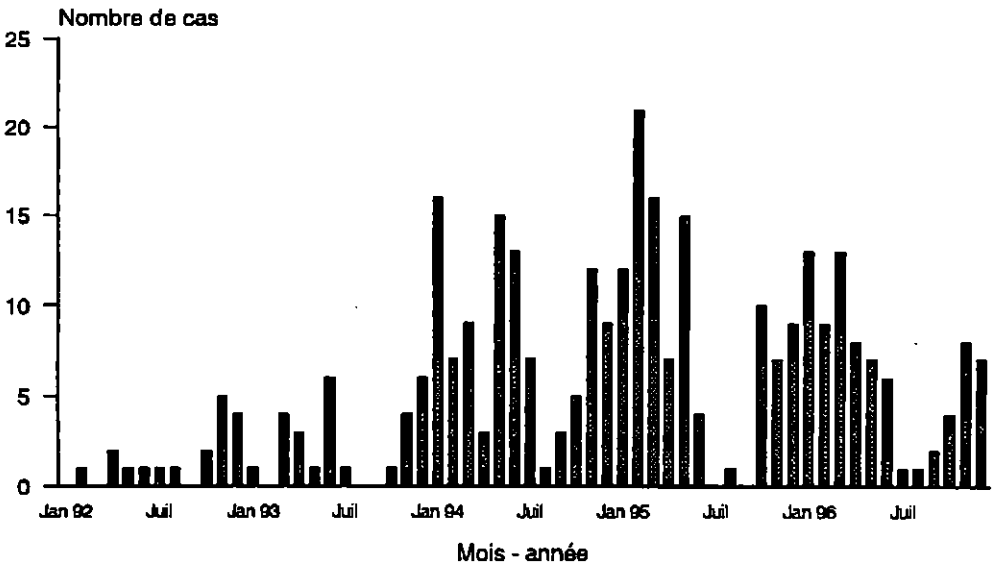
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
Laurentides et P. Québec, 1990-1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Scarlatine

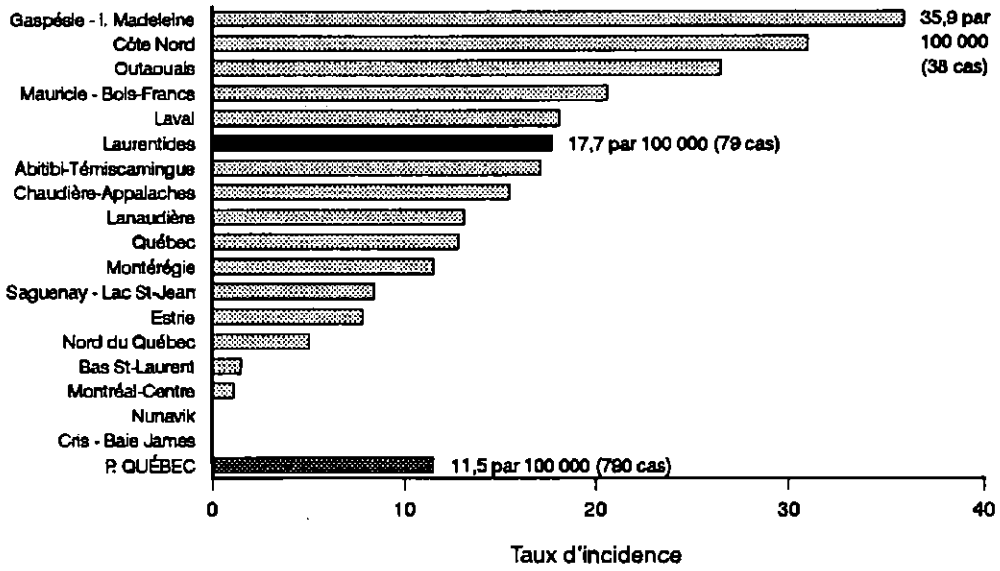
Nombre de cas déclarés par mois
Laurentides, 1992-1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Scarlatine

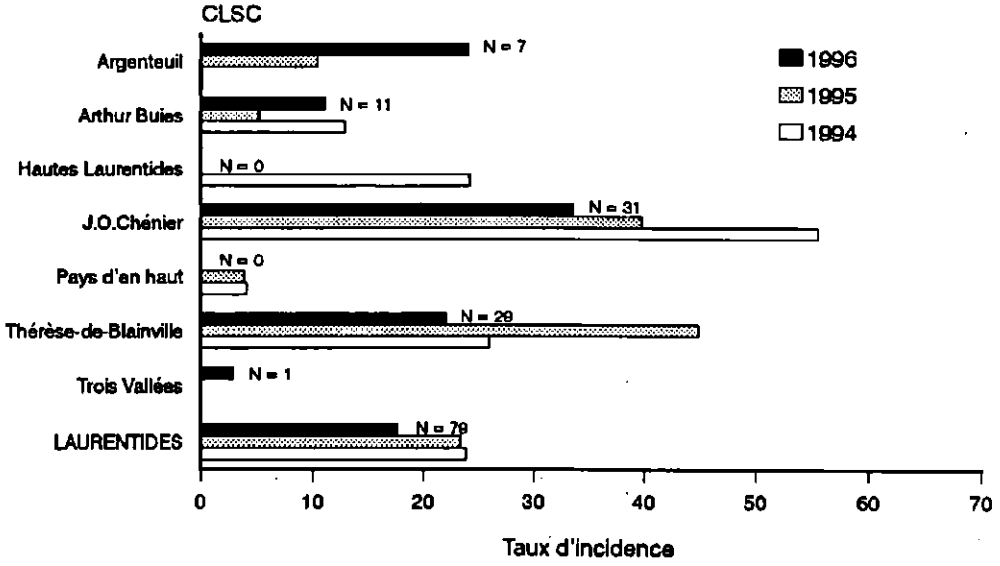
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
par RSS, 1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Scarlatine

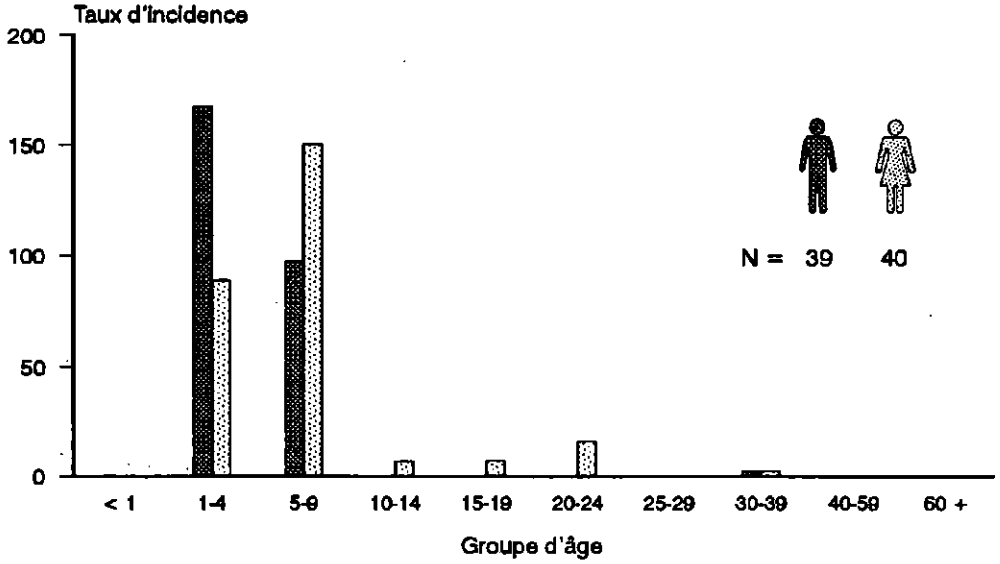
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
par CLSC, Laurentides, 1994-1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Scarlatine

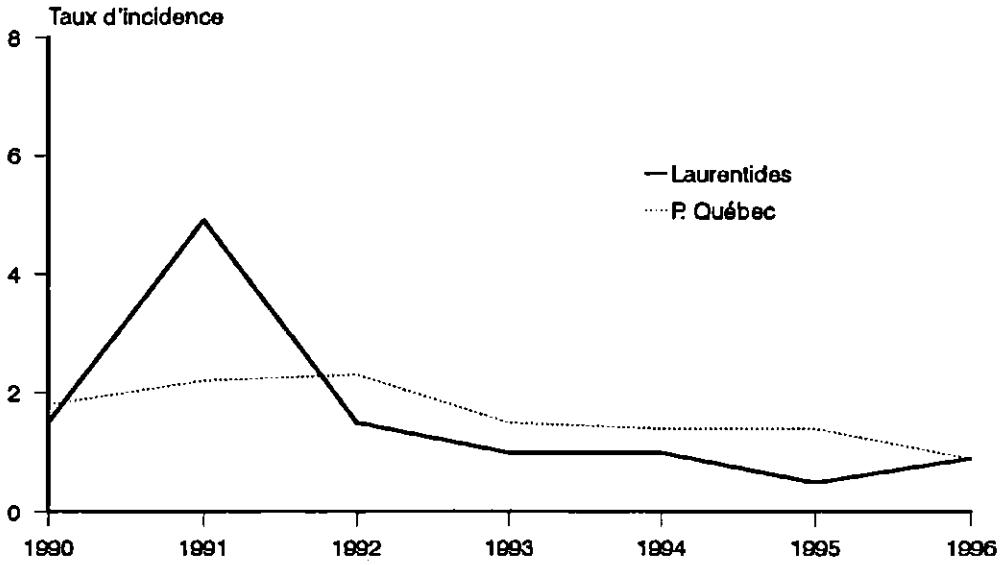
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année par groupe d'âge et sexe, Laurentides, 1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Infection à méningocoque

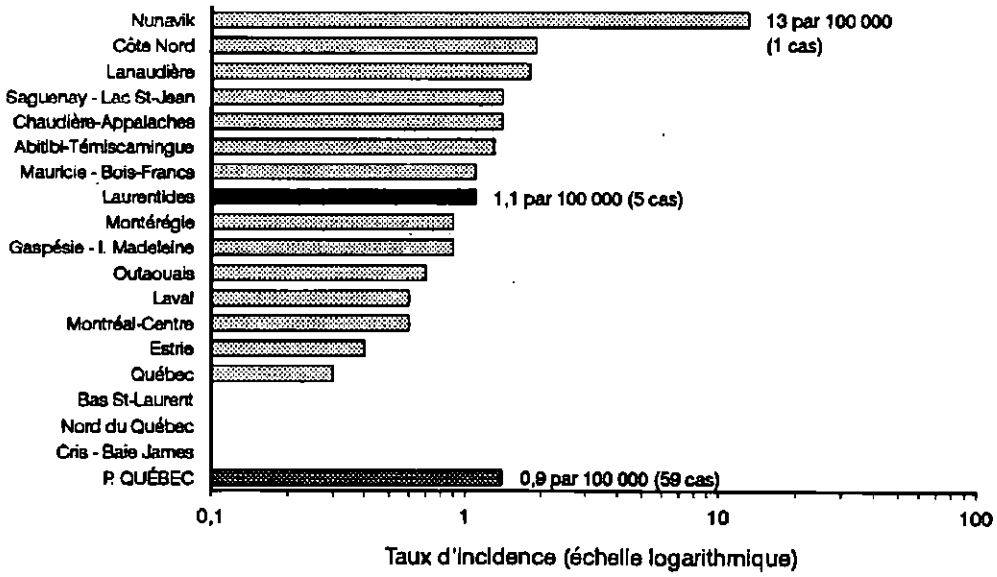
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
Laurentides et P. Québec, 1990-1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Infection à méningocoque

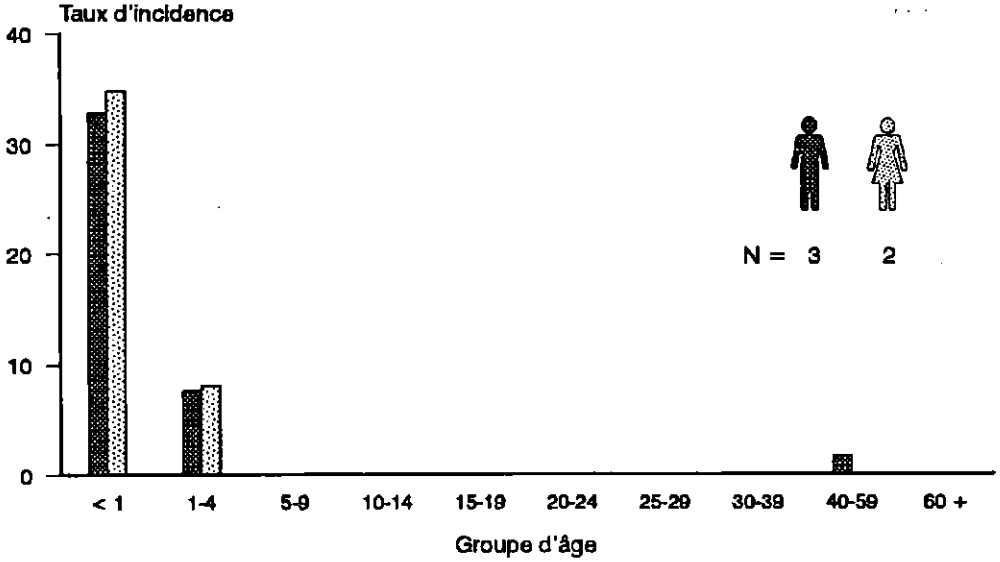
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
par RSS, 1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Infection à méningocoque

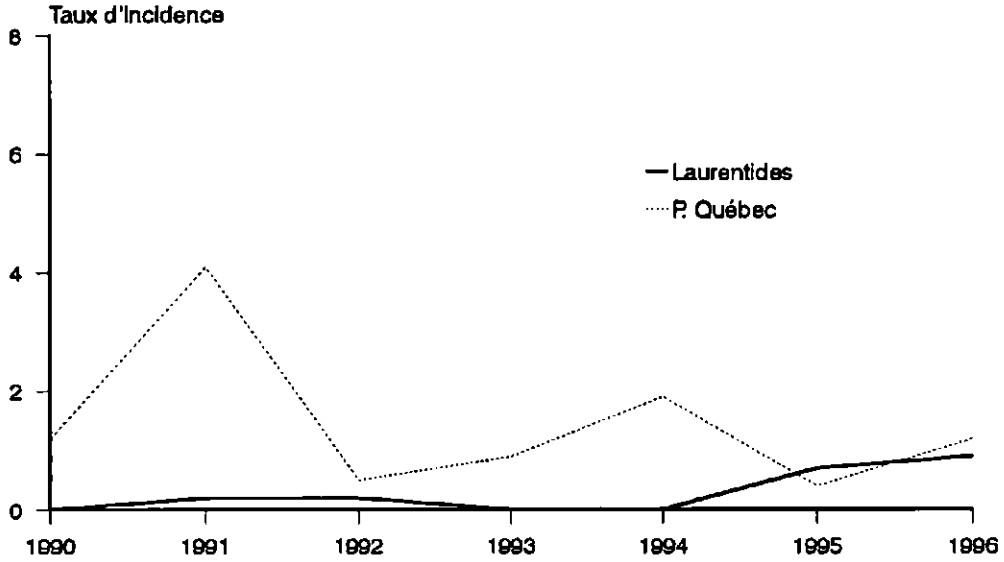
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année par groupe d'âge et sexe, Laurentides, 1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Rougeole

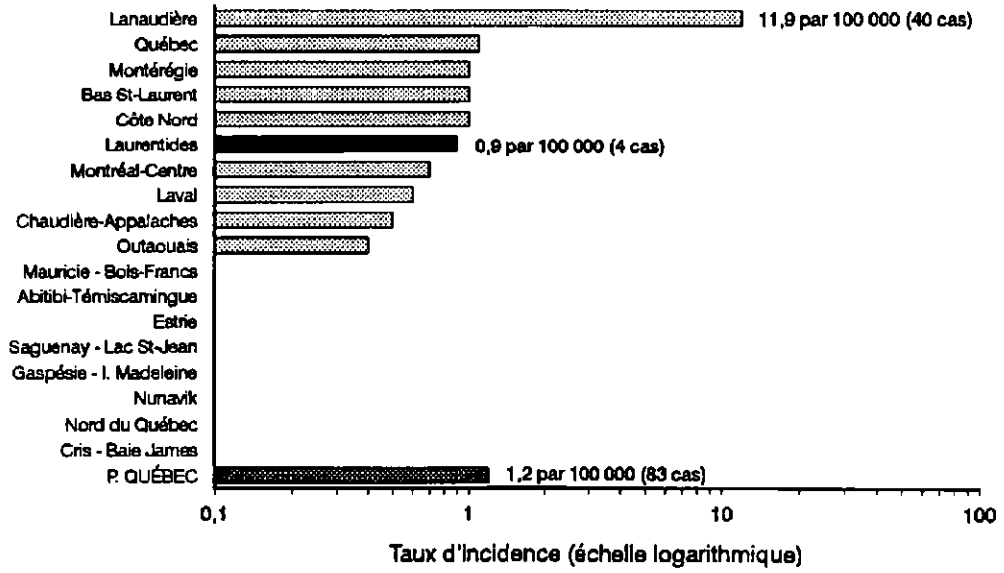
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
Laurentides et P. Québec, 1990-1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Rougeole

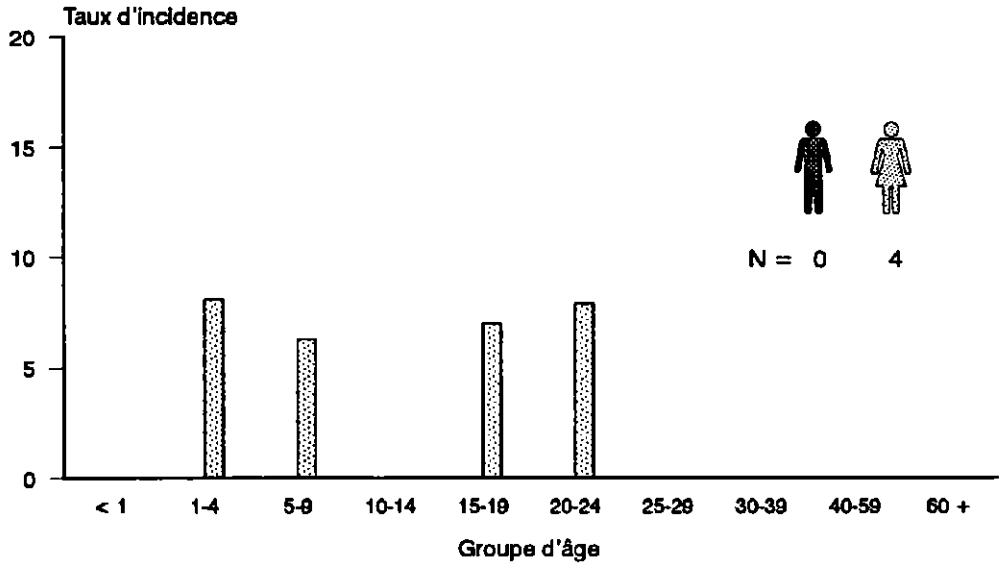
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
par RSS, 1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Rougeole

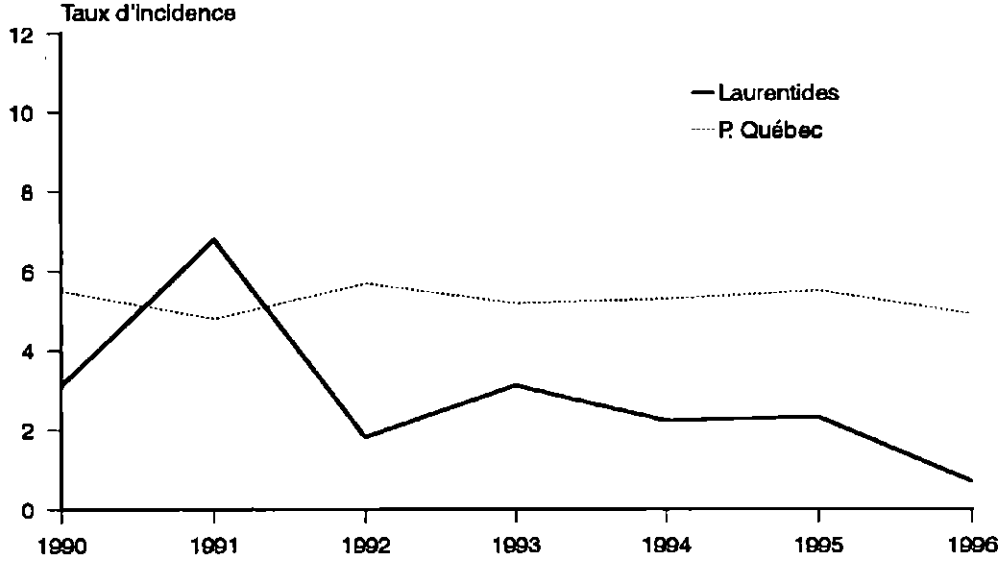
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
par groupe d'âge et sexe, Laurentides, 1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Tuberculose

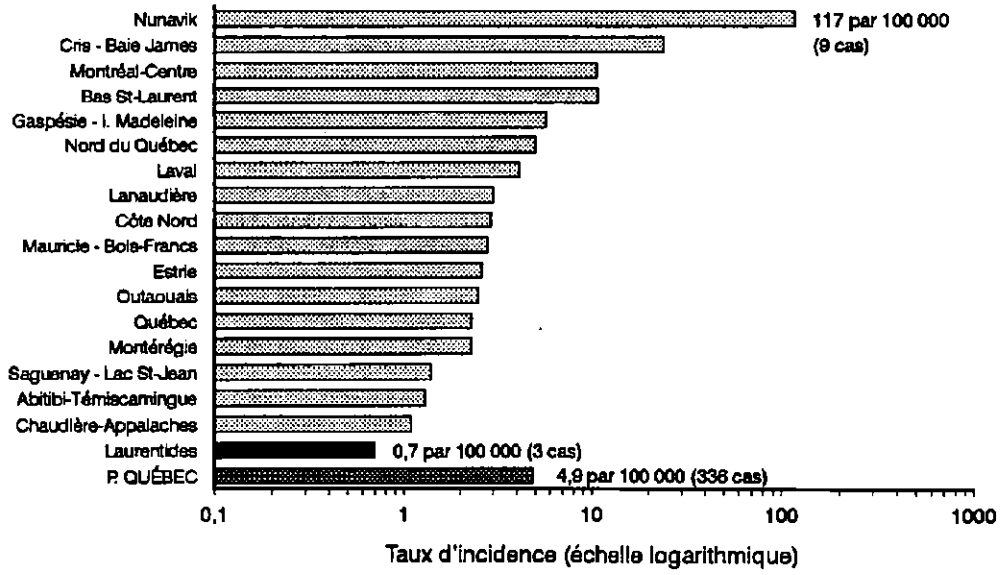
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
Laurentides et P. Québec, 1990-1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Tuberculose

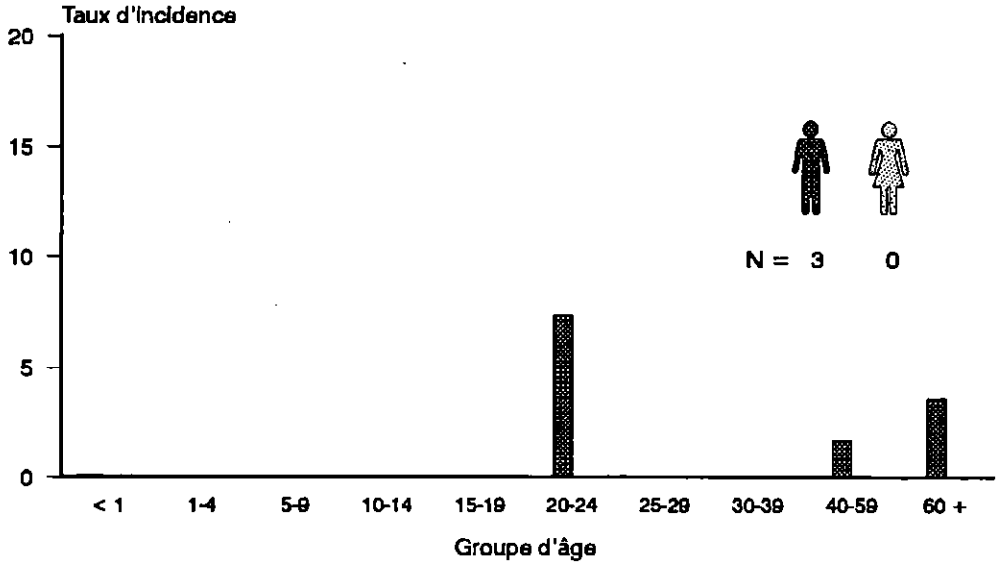
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
par RSS, 1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Tuberculose

Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année par groupe d'âge et sexe, Laurentides, 1996

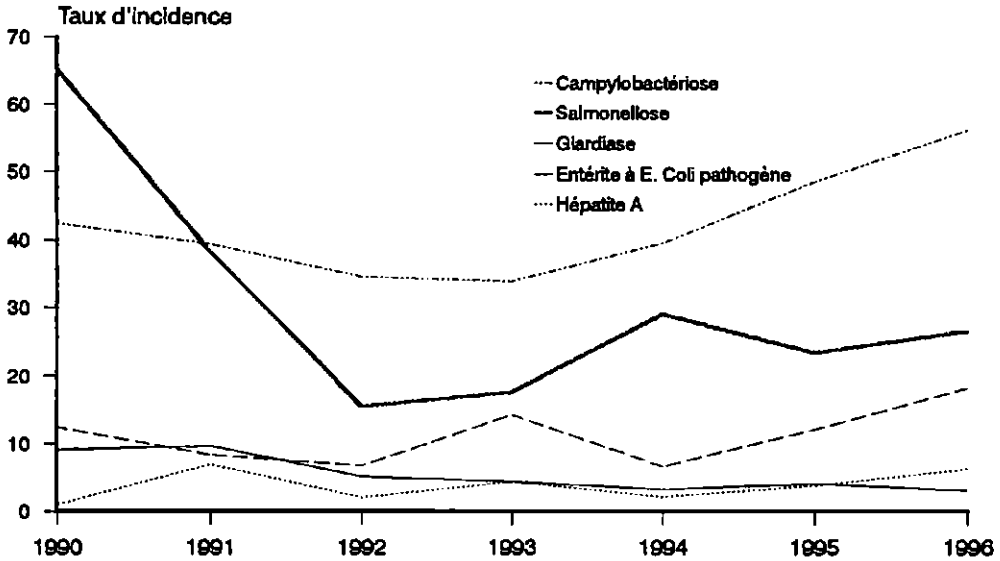


Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

MALADIES TRANSMISES PAR VOIE FÉCALE-ORALE : CAMPYLOBACTÉRIOSE, SALMONELLOSE, GIARDIASE, ENTÉRITE À *E. COLI*, YERSINIOSE, HÉPATITE A

Maladies transmises par voie fécale-orale

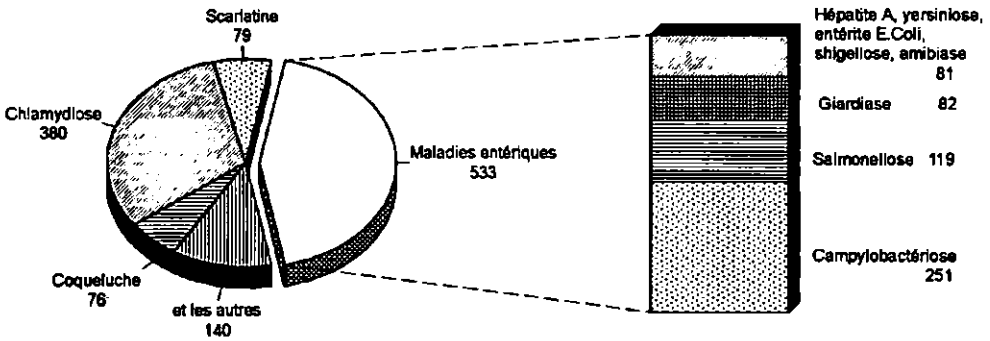
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
Laurentides, 1990-1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Répartition des MADO entériques

Laurentides, 1996

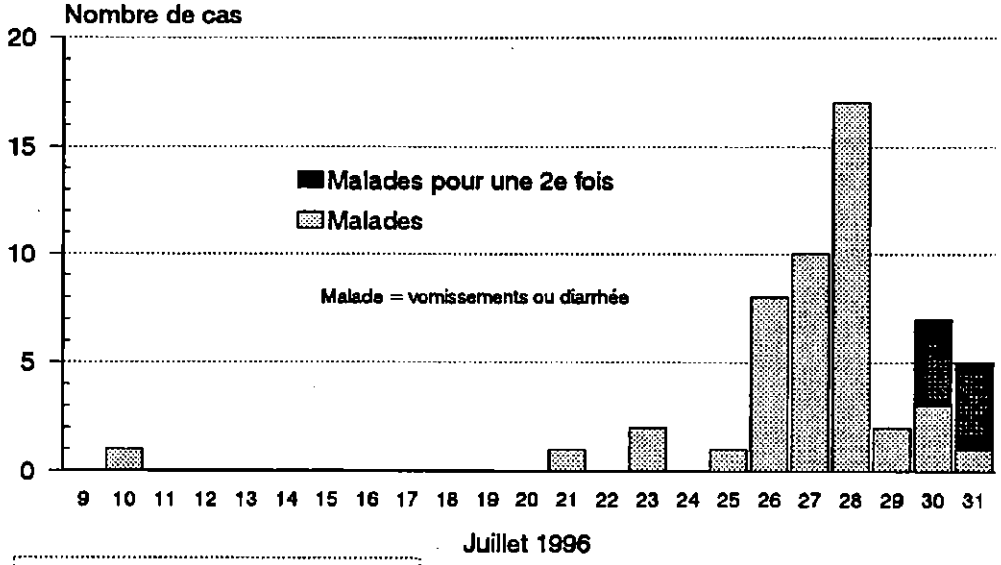


Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Éclosion de gastro-entérite

dans un camp de vacances des Laurentides, juillet 1996

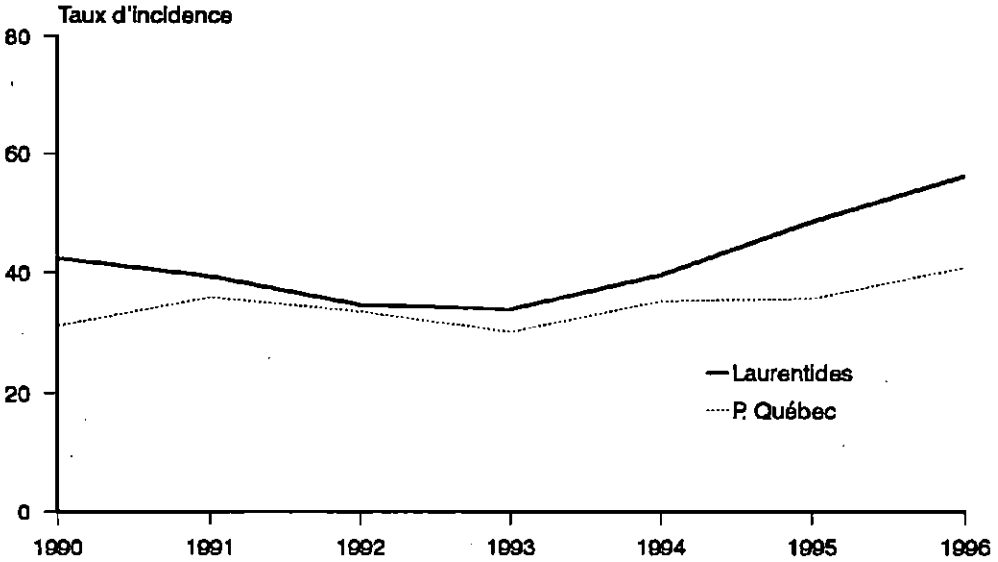
Courbe épidémique



Source : Sylvie Provost, DRSP des Laurentides

Campylobactériose

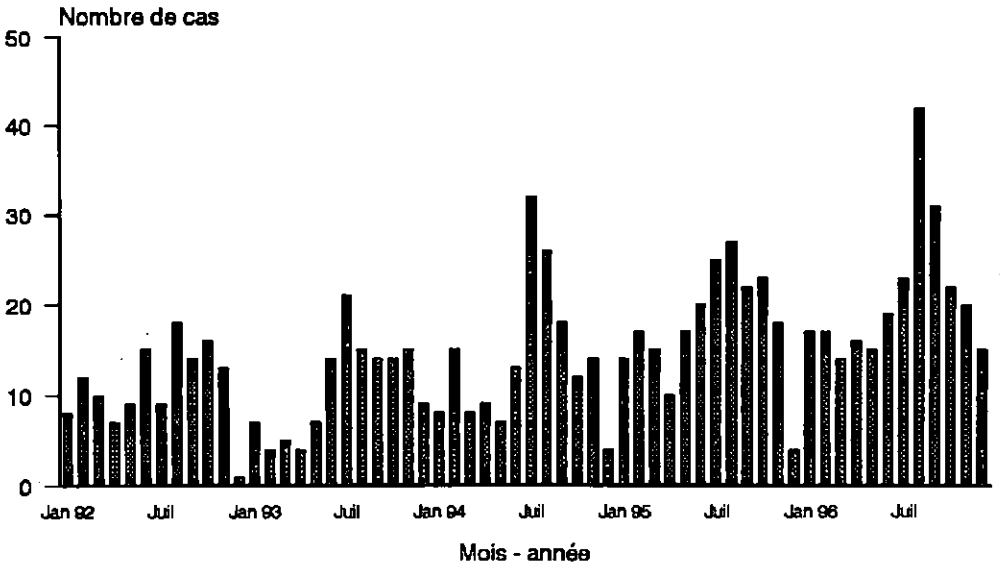
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
Laurentides et P. Québec, 1990-1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Campylobactériose

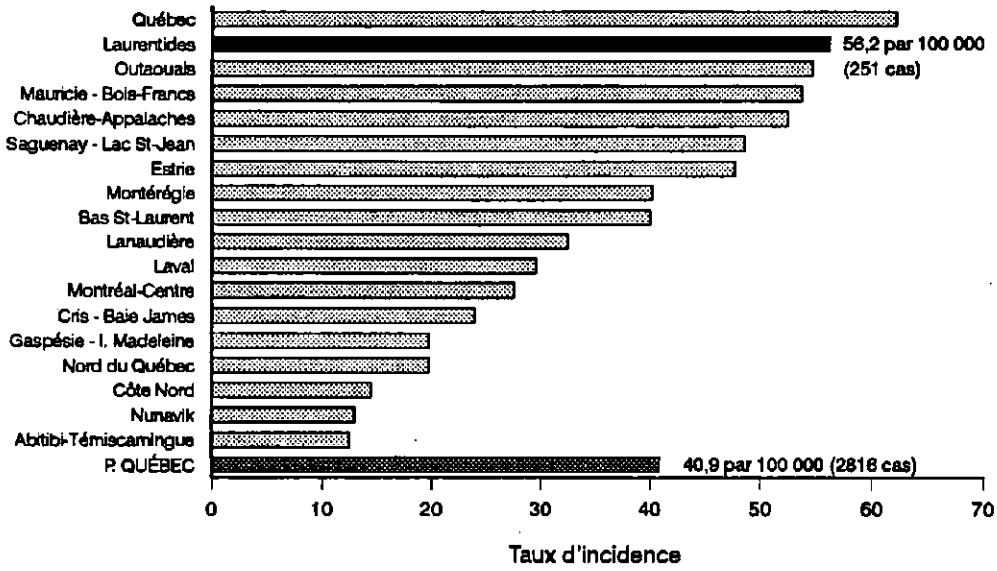
Nombre de cas déclarés par mois
Laurentides, 1992-1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Campylobactériose

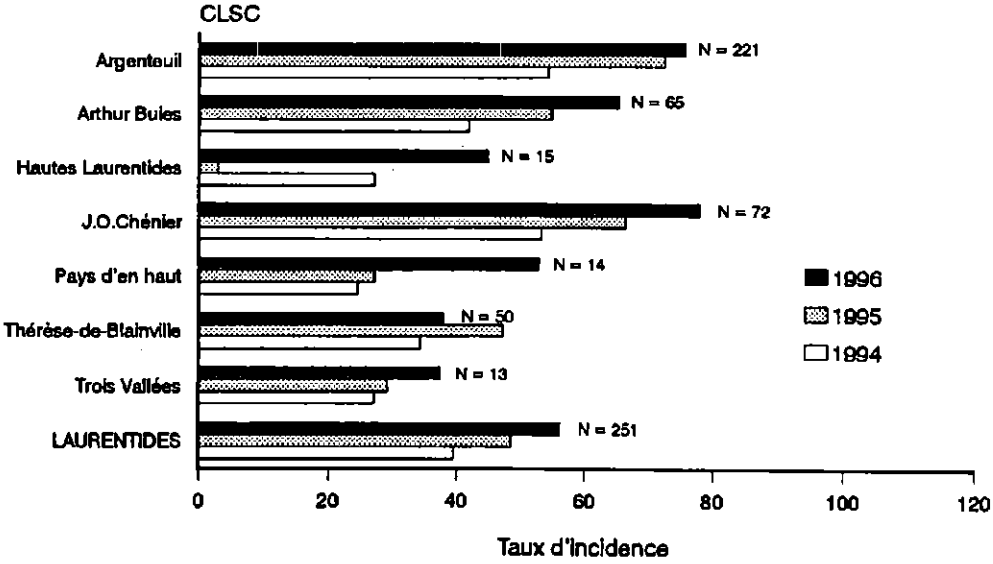
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année par RSS, 1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Campylobactériose

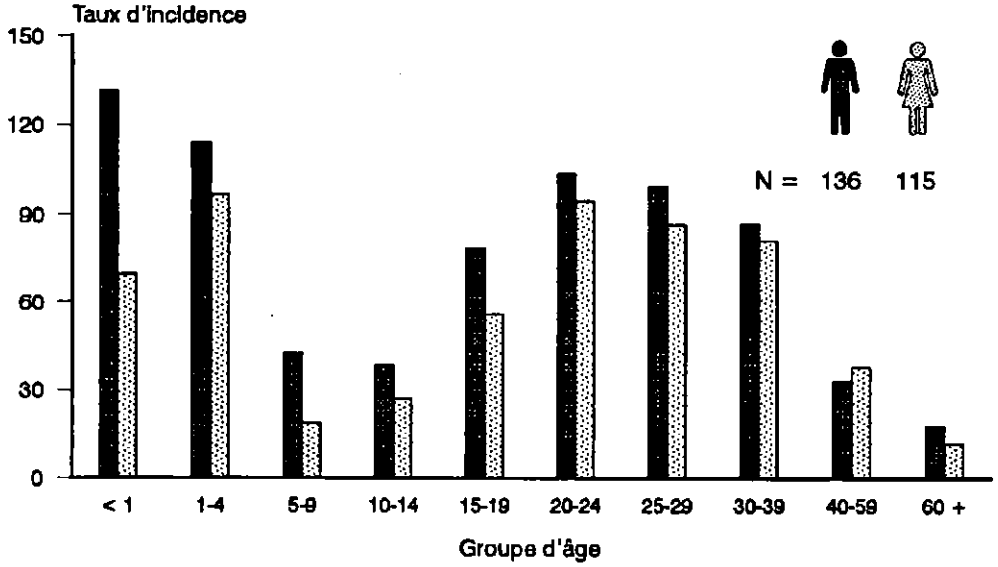
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année par CLSC, Laurentides, 1994-1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Campylobactériose

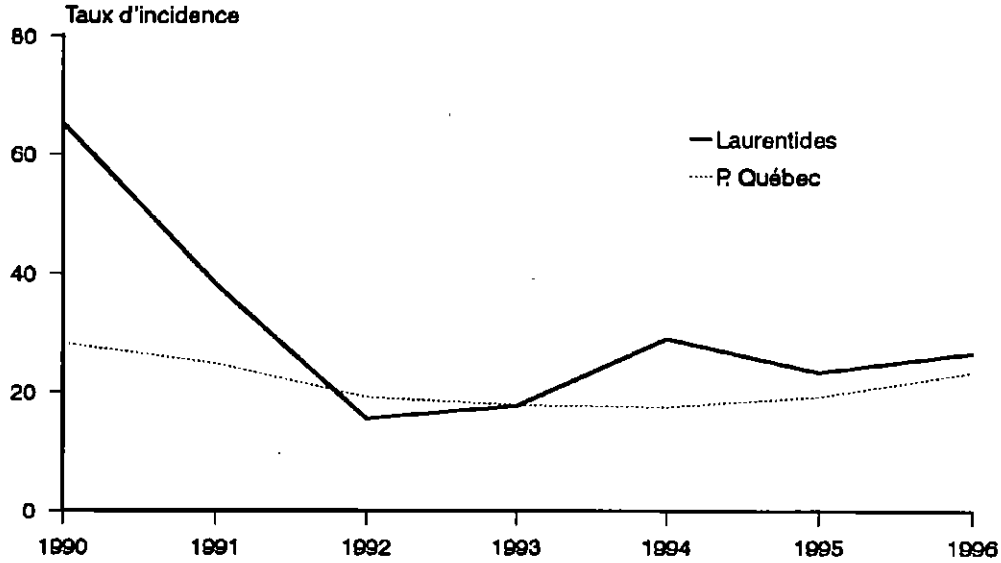
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année par groupe d'âge et sexe, Laurentides, 1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Salmonellose

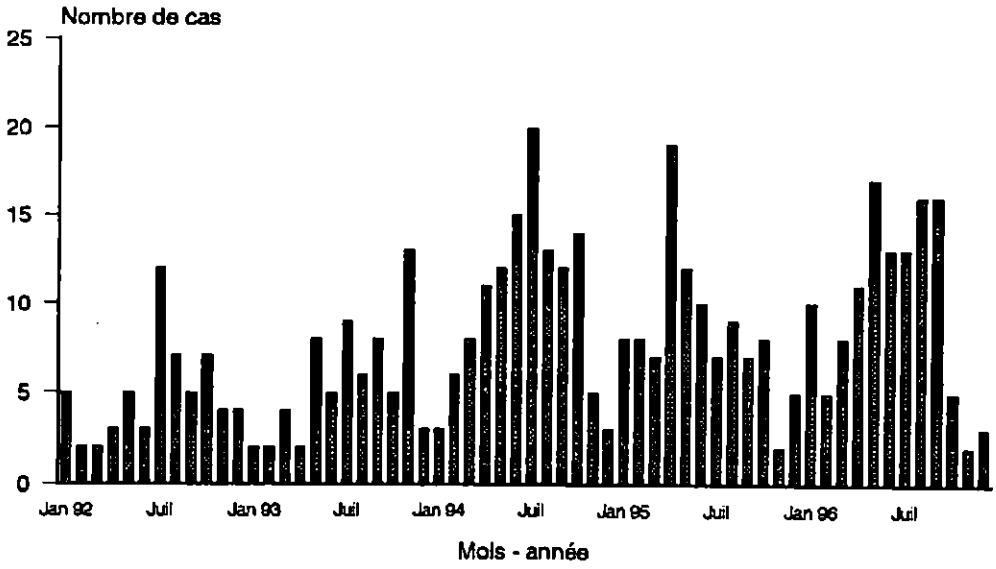
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
Laurentides et P. Québec, 1990-1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Salmonellose

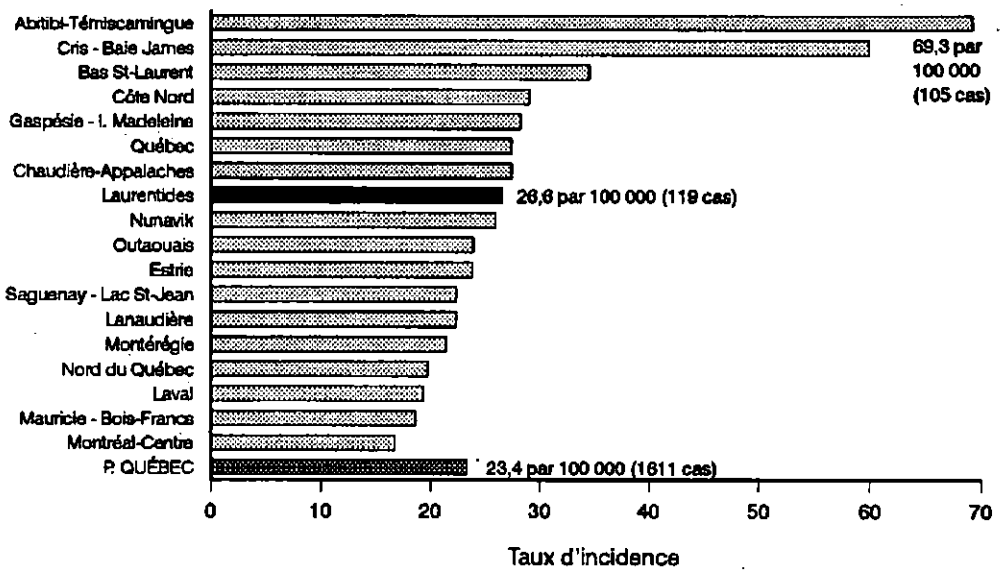
Nombre de cas déclarés par mois
Laurentides, 1992-1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Salmonellose

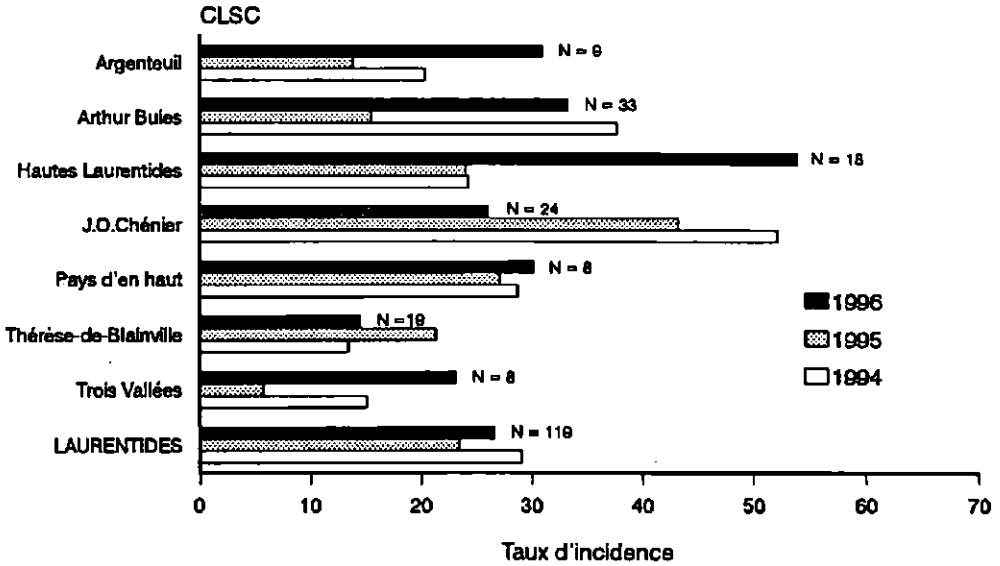
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année par RSS, 1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Salmonellose

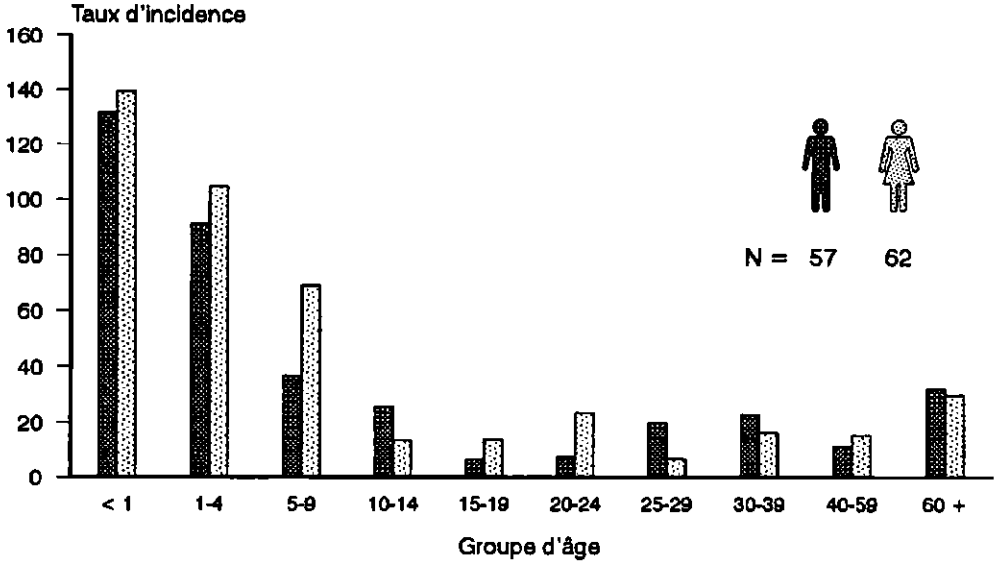
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année par CLSC, Laurentides, 1994-1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Salmonellose

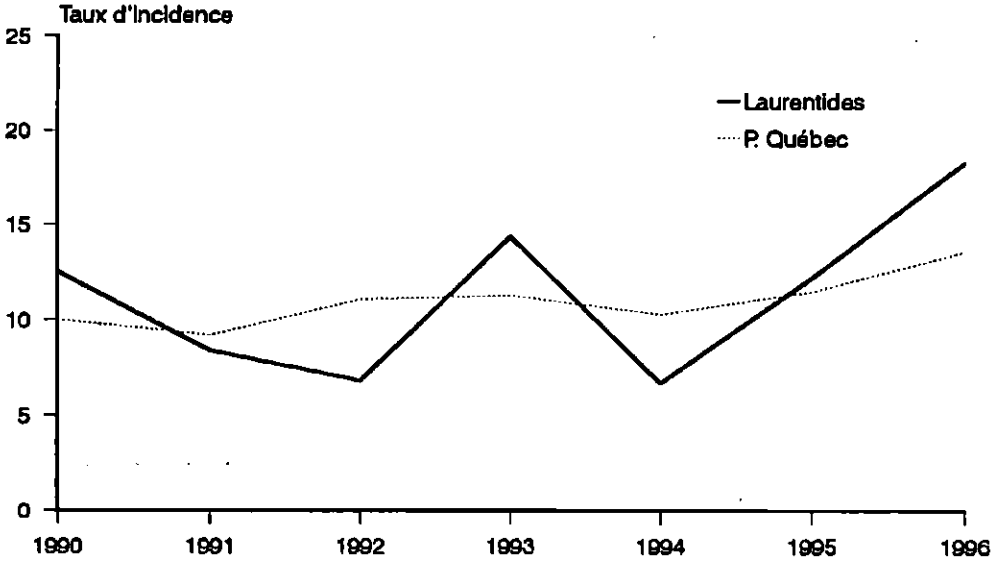
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
par groupe d'âge et sexe, Laurentides, 1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Giardiase

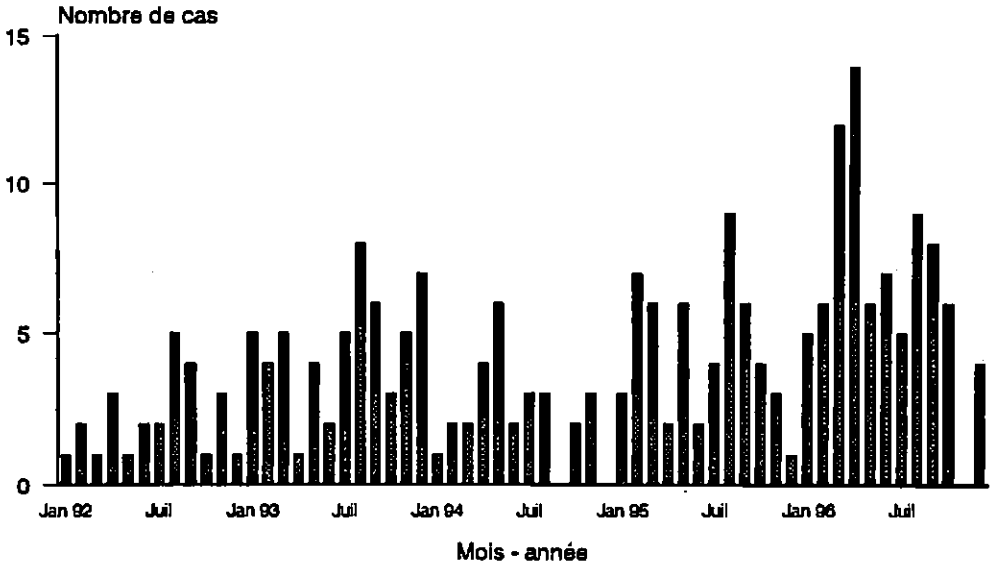
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
Laurentides et P. Québec, 1990-1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Giardiase

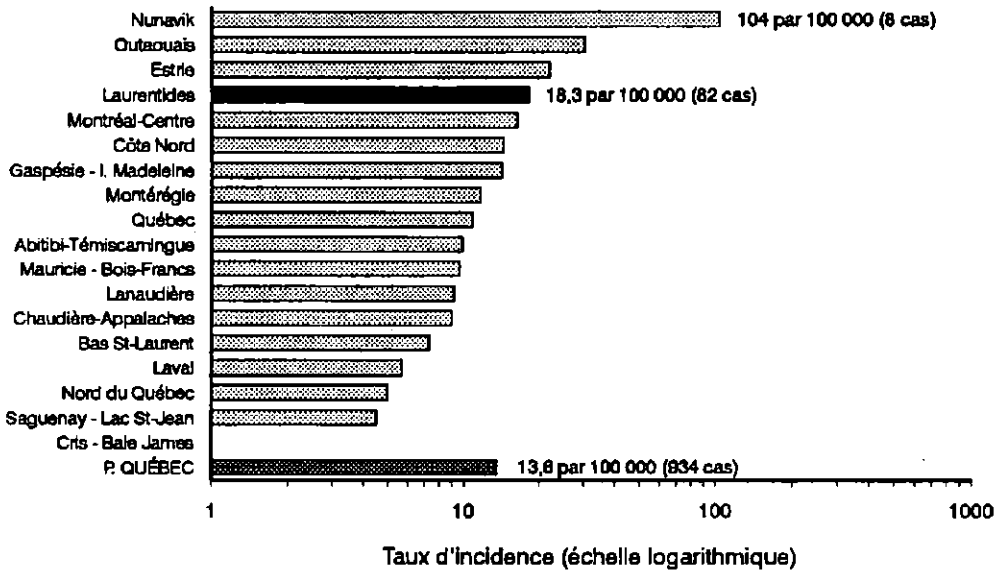
Nombre de cas déclarés par mois
Laurentides, 1992-1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Giardiase

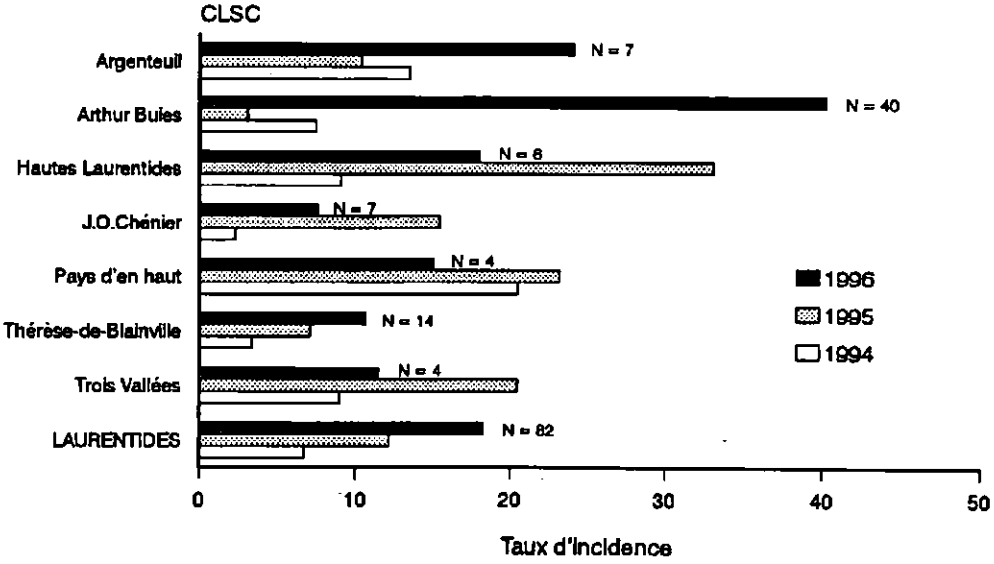
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
par RSS, 1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Giardiase

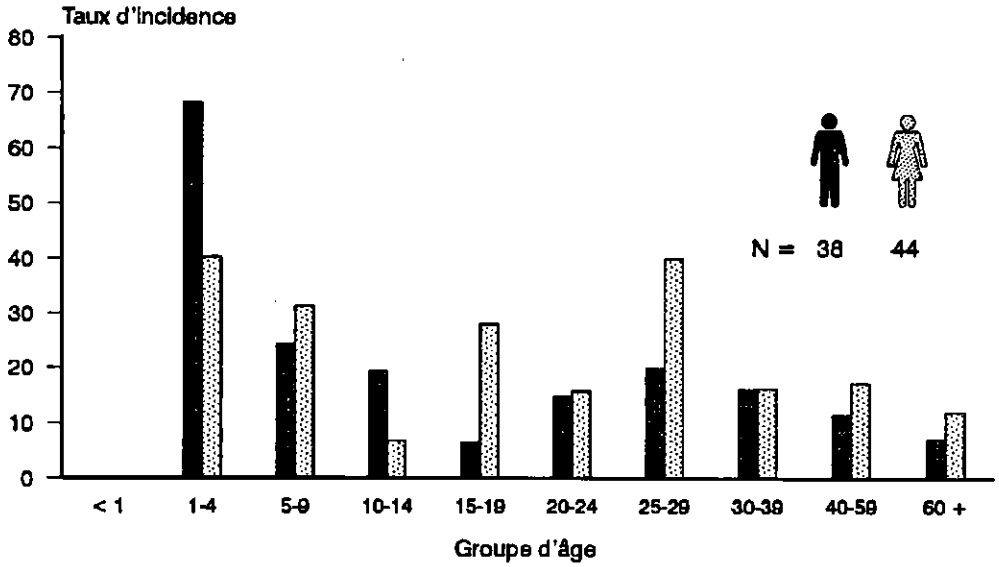
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
par CLSC, Laurentides, 1994-1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ).

Giardiase

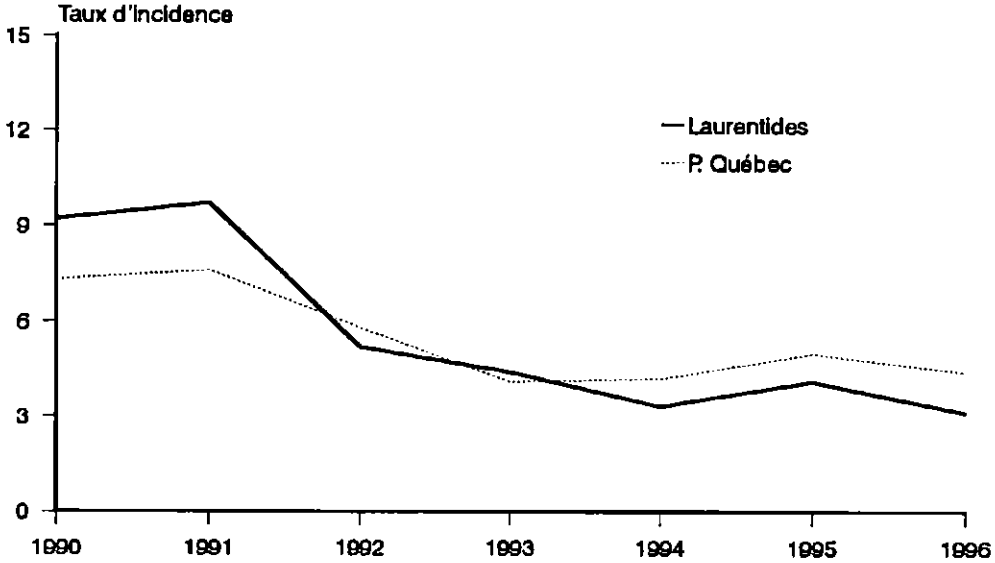
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année par groupe d'âge et sexe, Laurentides, 1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Entérite à *E.Coli* pathogène

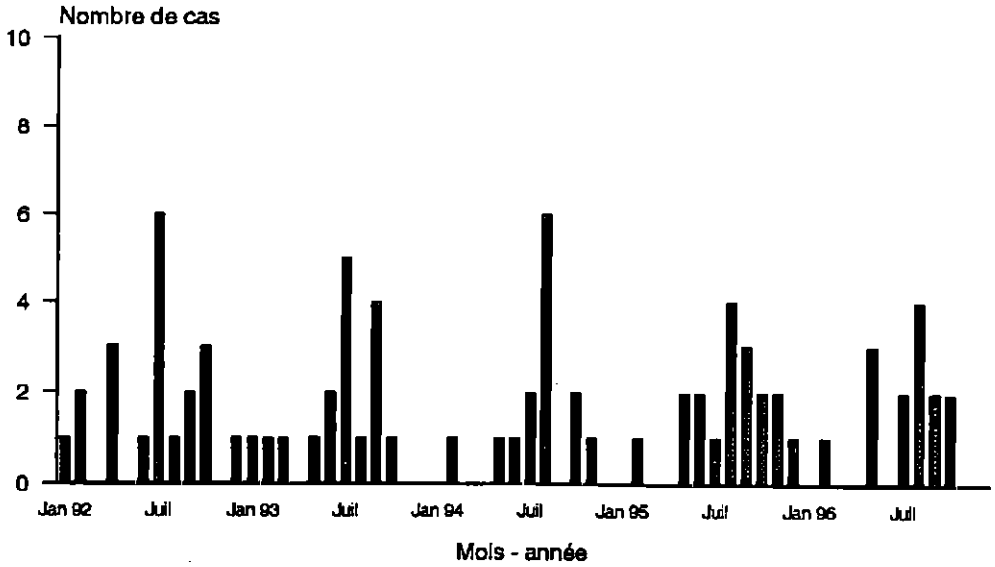
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
Laurentides et P. Québec, 1990-1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

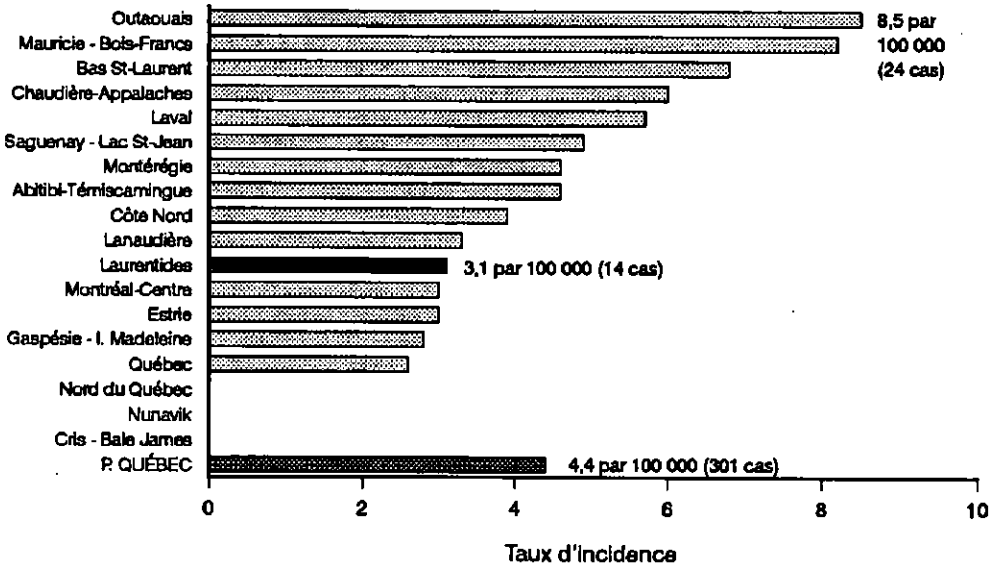
Entérite à *E.Coli* pathogène

Nombre de cas déclarés par mois
Laurentides, 1992-1996



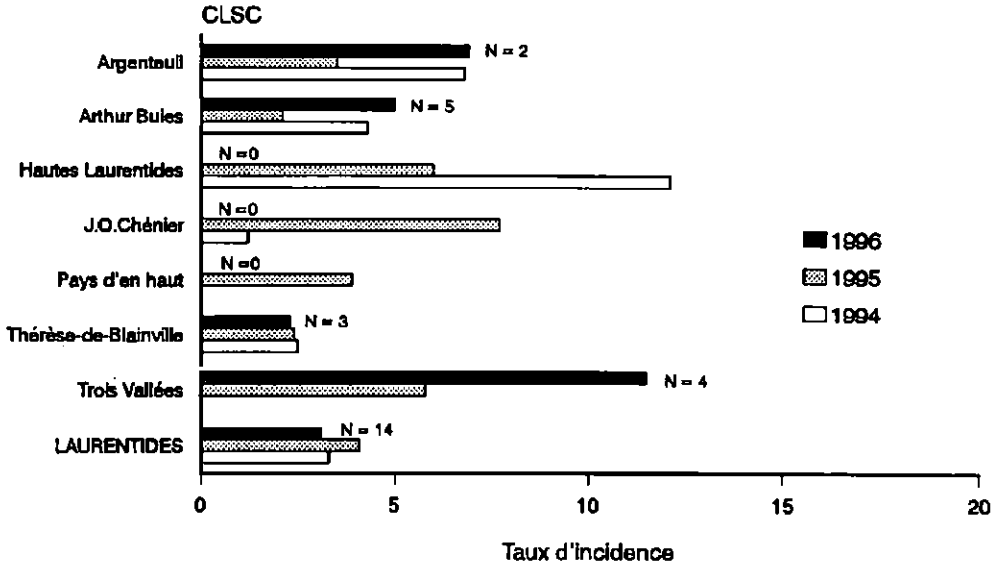
Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Entérite à *E.Coli* pathogène
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
par RSS, 1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

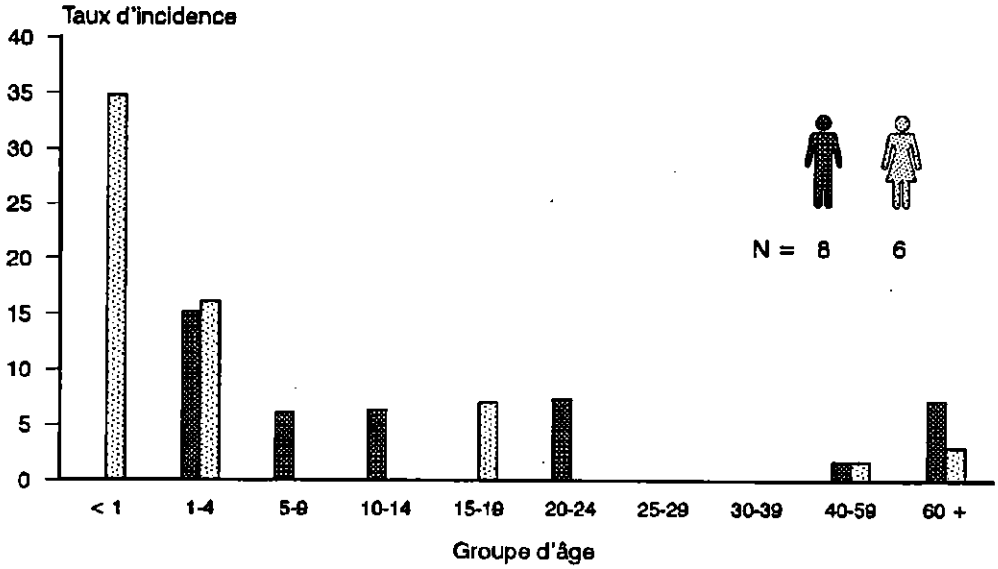
Entérite à *E.Coli* pathogène
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
par CLSC, Laurentides, 1994-1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Entérite à *E.Coli* pathogène

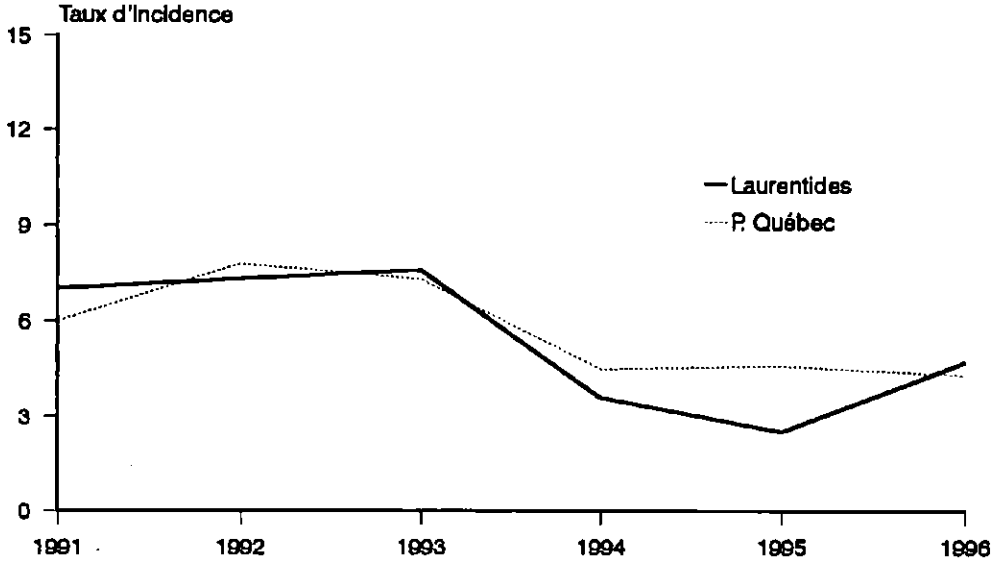
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année par groupe d'âge et sexe, Laurentides, 1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Yersiniose

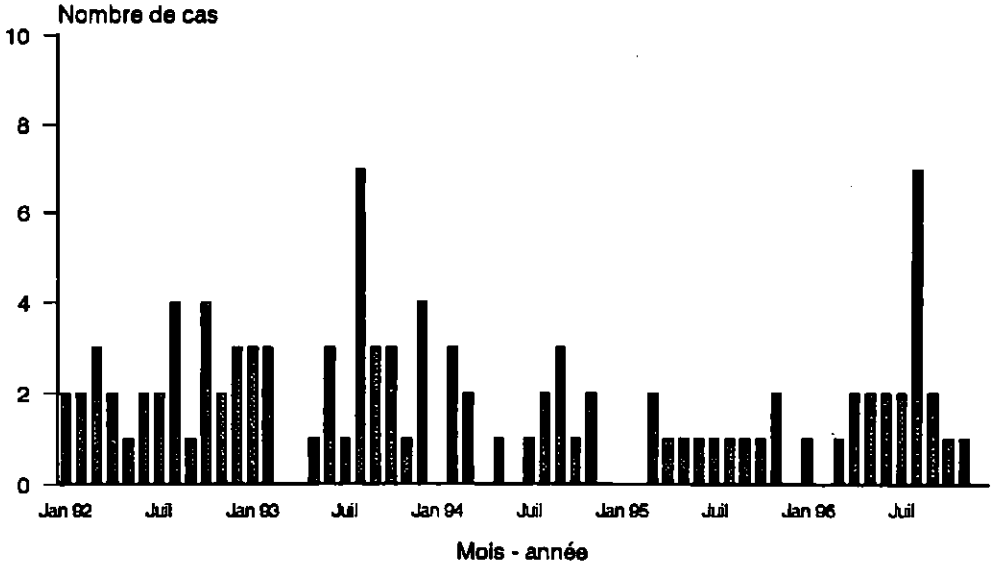
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
Laurentides et P. Québec, 1991-1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Yersiniose

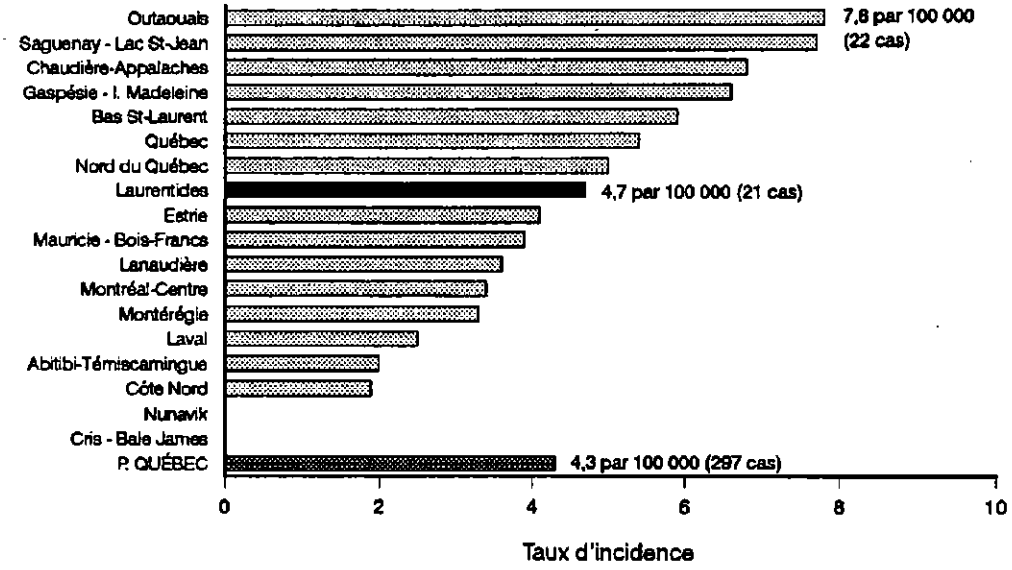
Nombre de cas déclarés par mois
Laurentides, 1992-1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Yersiniose

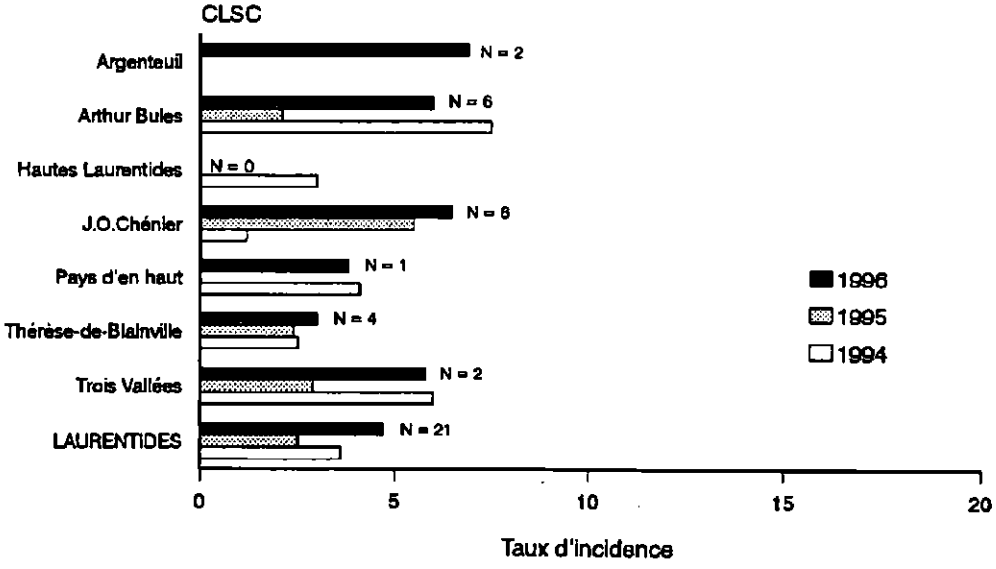
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année par RSS, 1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Yersiniose

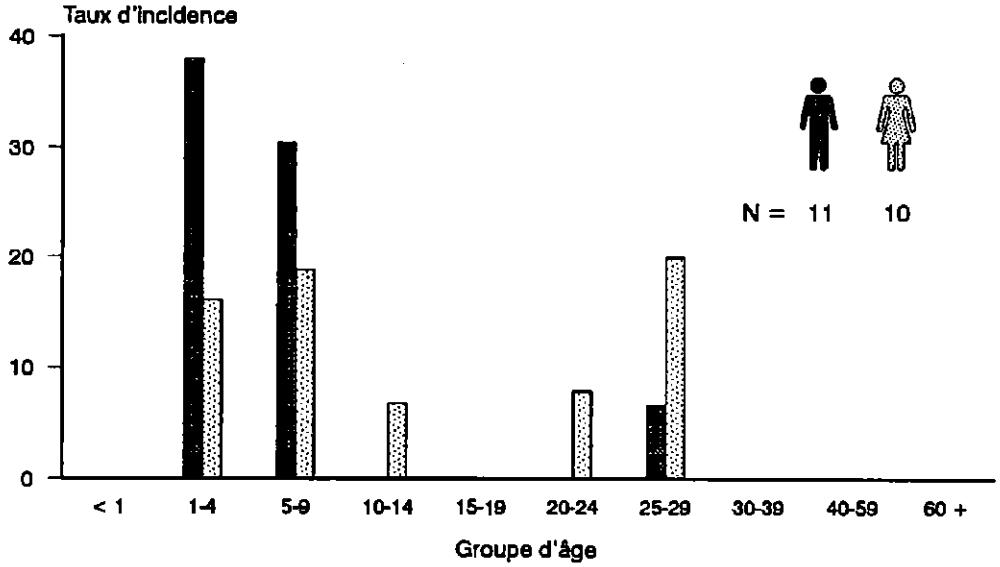
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année par CLSC, Laurentides, 1994-1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Yersiniose

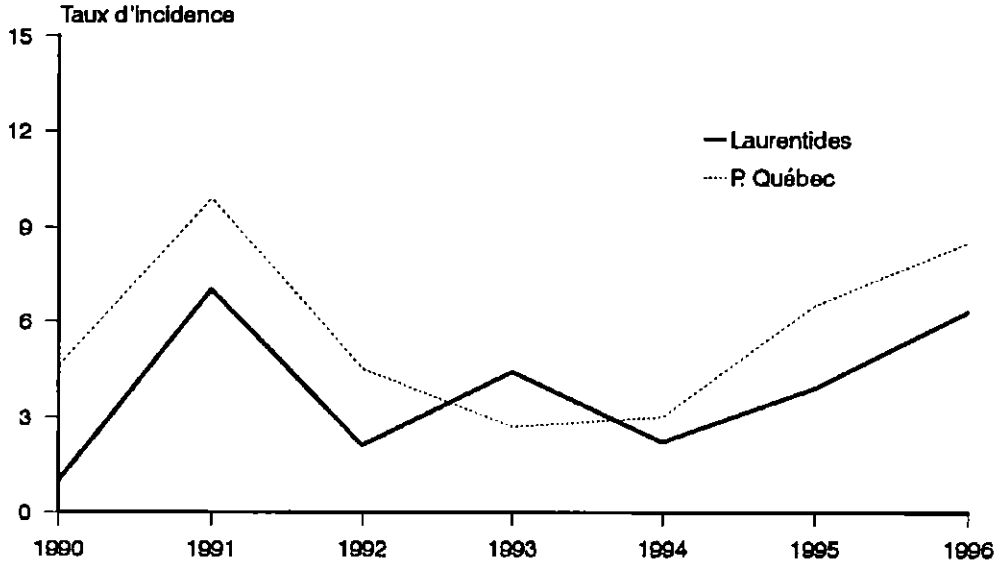
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année par groupe d'âge et sexe, Laurentides, 1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Hépatite A

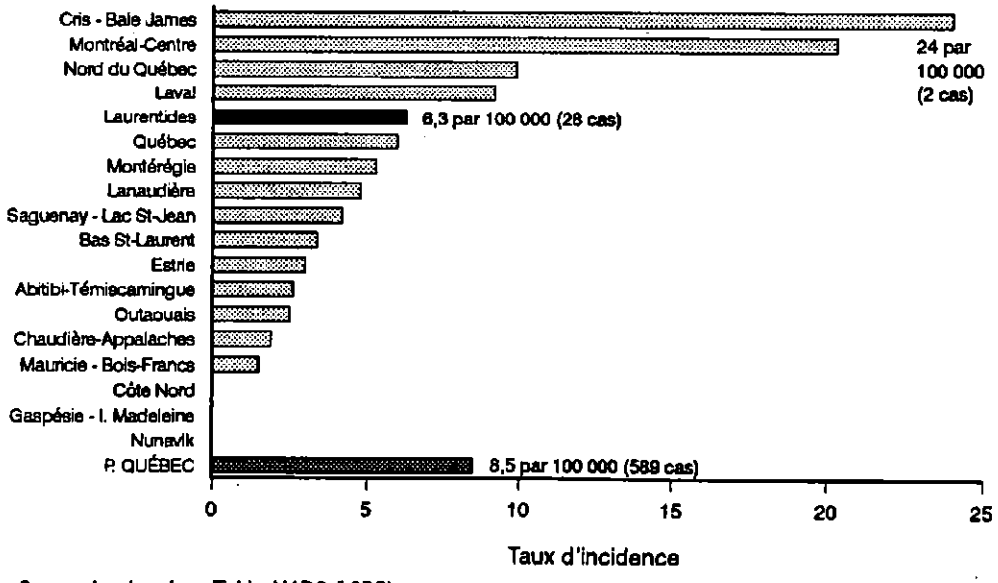
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
Laurentides et P. Québec, 1990-1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Hépatite A

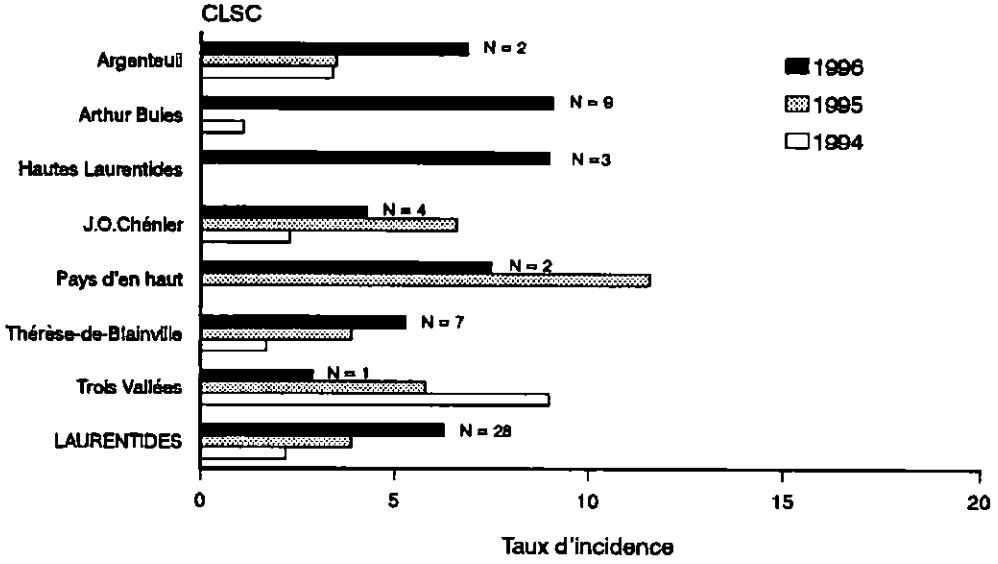
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
par RSS, 1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Hépatite A

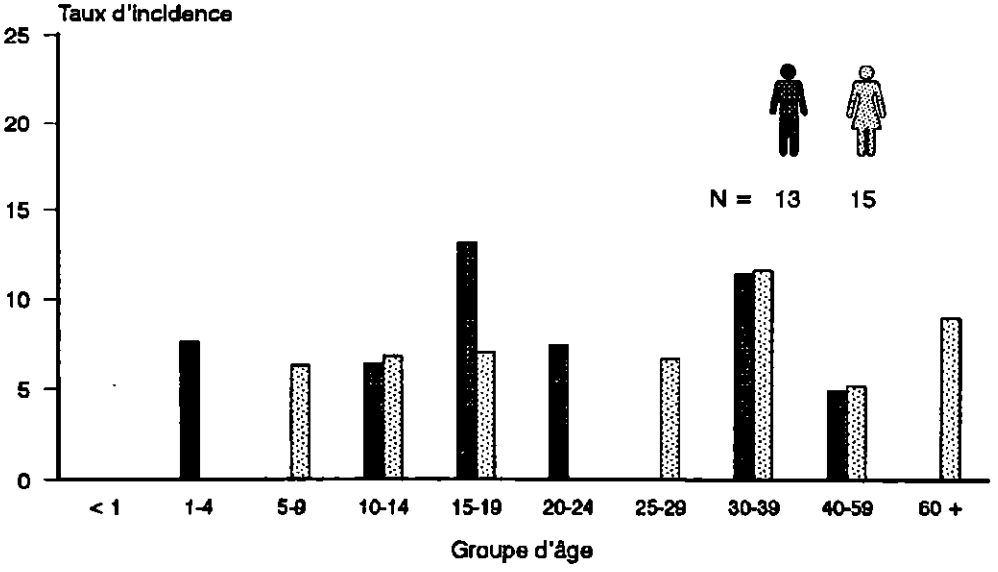
Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
par CLSC, Laurentides, 1994-1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

Hépatite A

Incidence de cas déclarés par 100 000 personnes-année
par groupe d'âge et sexe, Laurentides, 1996

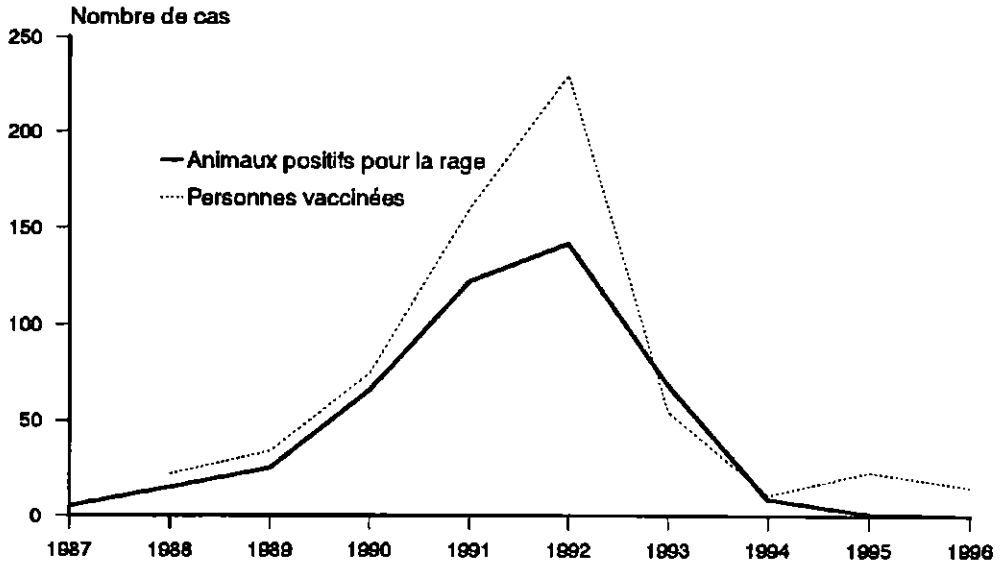


Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

LA RAGE

Rage

Nombre d'animaux atteints et de personnes vaccinées
Laurentides, 1987-1996



Source des données : Fichier MADO (LSPQ)

TABLEAUX

MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
NOMBRE DE CAS DÉCLARÉS PAR ANNÉE
LAURENTIDES ET PROVINCE DE QUÉBEC, 1994-1996

MALADIE	LAURENTIDES			PROVINCE DE QUÉBEC		
	1994	1995	1996	1994	1995	1996
Amibiase	1	6	6	238	198	250
Botulisme	0	0	0	4	13	10
Brucellose	0	0	0	0	3	0
Campylobactériose	166	212	251	2434	2462	2816
Chancre mou	0	0	0	1	1	1
Chlamydiose génitale	492	441	380	7900	7048	6656
Chlamydiose oculaire	3	1	1	19	21	22
Chlamydiose pulmonaire	1	1	1	8	8	6
Choléra	0	0	0	1	0	0
Coqueluche	324	288	76	4429	4319	1320
Diarrhée épidémique	1	1	1	20	20	92
Entérite à E. Coli	14	18	14	289	342	301
Entérite à Y. Entérocolitica	15	11	21	307	314	297
Fièvre paratyphoïde	0	0	0	3	5	6
Fièvre Q	0	1	3	7	12	20
Fièvre typhoïde	0	1	1	27	26	10
Giardiase	28	53	82	713	794	934
H. Influenzae, bactériémie	0	1	0	11	10	7
H. Influenzae, méningite	0	0	0	8	10	3
H. Influenzae, autres formes	0	0	0	8	4	5
Hépatite sans précision	0	0	0	86	126	118
Hépatite A	9	17	28	210	445	589
Hépatite B aiguë	34	17	11	347	268	259
Hépatite B porteur	58	69	50	1247	1185	1029
Hépatite B sans précision	0	0	0	310	241	279
Hépatite C sans précision	0	0	0	2	17	21
Herpès néonatal	1	0	0	1	1	1
Infection gonococcique génito-urinaire	11	14	8	692	568	426
Infection gonococcique oculaire	0	0	0	1	3	1
Infection gonococcique autre	0	0	0	57	35	52
Infection à méningocoque	4	2	5	95	96	59

MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
NOMBRE DE CAS DÉCLARÉS PAR ANNÉE
LAURENTIDES ET PROVINCE DE QUÉBEC, 1994-1996

MALADIE	LAURENTIDES			PROVINCE DE QUÉBEC		
	1994	1995	1996	1994	1995	1996
Lèpre	0	0	0	3	4	3
Lymphogranulomatose vénérienne	0	0	0	1	0	1
Légionellose	0	0	1	11	18	32
Méningite à entérovirus Coxsackie	9	2	4	90	16	31
Méningite à entérovirus Echo	0	2	0	10	15	23
Méningite à entérovirus sans précision	0	0	1	17	4	4
Oreillons	6	7	5	83	75	79
Paludisme	1	0	1	54	110	117
Poliomyélite	0	0	0	0	2	0
Psittacose	0	0	0	1	0	3
Rougeole	0	3	4	128	31	83
Rubéole	4	6	0	63	48	55
Rubéole congénitale	0	0	0	1	0	1
Salmonellose	122	102	119	1206	1328	1611
Scarlatine	100	102	79	1305	966	790
Shigellose	13	10	13	303	330	285
SIDA	17	20	20	419	781	743
Streptocoques A invasifs	-	6	9	-	89	115
Streptocoques B invasifs	-	-	0	-	-	2
Streptocoques pneumoniae	-	-	0	-	-	11
Syphilis primaire	1	0	0	9	6	5
Syphilis secondaire	0	0	0	5	3	3
Syphilis latente (< 2 ans)	0	0	0	5	2	4
Syphilis latente (> 2ans)	5	0	0	59	50	43
Syphilis autre	1	0	0	25	19	8
Tétanos	0	0	0	1	4	2
Toxi-infection alimentaire	3	3	10	130	175	167
Trichinose	0	0	0	0	1	0
Tuberculose	9	10	3	362	381	336
Tularémie	0	0	0	7	7	7
TOTAL	**1395**	**1427**	**1208**	**23773**	**23060**	**20154**

MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
INCIDENCE DE CAS DÉCLARÉS PAR 100 000 PERSONNES-ANNÉE
LAURENTIDES ET PROVINCE DE QUÉBEC, 1994-1996

MALADIE	LAURENTIDES			PROVINCE DE QUÉBEC		
	1994	1995	1996	1994	1995	1996
Amibiase	0,2	1,4	1,3	3,5	2,9	3,6
Botulisme	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1
Brucellose	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Campylobactériose	39,6	48,6	56,2	35,3	35,7	40,9
Chancre mou	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chlamydiose génitale	117,4	101,1	85,0	114,6	102,3	98,6
Chlamydiose oculaire	0,7	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
Chlamydiose pulmonaire	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
Choléra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche	77,3	66,0	17,0	64,3	62,7	19,2
Diarrhée épidémique	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	1,3
Entérite à E. Coli	3,3	4,1	3,1	4,2	5,0	4,4
Entérite à Y. Entérocolitica	3,6	2,5	4,7	4,5	4,6	4,3
Fièvre paratyphoïde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Fièvre Q	0,0	0,2	0,7	0,1	0,2	0,3
Fièvre typhoïde	0,0	0,2	0,2	0,4	0,4	0,1
Giardiase	8,7	12,2	18,3	10,3	11,5	13,6
H. Influenzae, bactériémie	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,1
H. Influenzae, méningite	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
H. Influenzae, autres formes	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Hépatite sans précision	0,0	0,0	0,0	1,2	1,8	1,7
Hépatite A	2,2	3,9	6,3	3,0	6,5	8,5
Hépatite B aiguë	8,1	3,9	2,5	5,0	3,9	3,8
Hépatite B porteur	13,8	15,8	11,2	18,1	17,2	14,9
Hépatite B sans précision	0,0	0,0	0,0	4,5	3,5	4,0
Hépatite C sans précision	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3
Herpès néonatal	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection gonococcique génito-urinaire	2,6	3,2	1,8	10,0	8,2	6,2
Infection gonococcique oculaire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection gonococcique autre	0,0	0,0	0,0	0,8	0,5	0,8
Infection à méningocoque	1,0	0,5	1,1	1,4	1,4	0,9

MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
INCIDENCE DE CAS DÉCLARÉS PAR 100 000 PERSONNES-ANNÉE
LAURENTIDES ET PROVINCE DE QUÉBEC, 1994-1996

MALADIE	LAURENTIDES			PROVINCE DE QUÉBEC		
	1994	1995	1996	1994	1995	1996
Lèpre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Lymphogranulomatose vénérienne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Légionellose	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,5
Méningite à entérovirus Coxsackie	2,2	0,5	0,9	1,3	0,2	0,4
Méningite à entérovirus Echo	0,0	0,5	0,0	0,1	0,2	0,3
Méningite à entérovirus sans précision	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,1
Oreillons	1,4	1,6	1,1	1,2	1,1	1,1
Paludisme	0,2	0,0	0,2	0,7	1,5	1,7
Poliomyélite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Psittacose	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole	0,0	0,7	0,9	1,9	0,4	1,2
Rubéole	1,0	1,4	0,0	0,9	0,7	0,8
Rubéole congénitale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Salmonellose	29,1	23,4	26,6	17,5	19,3	23,4
Scarlatine	23,9	23,4	17,7	18,9	14,0	11,5
Shigellose	3,1	2,3	2,9	4,4	4,8	4,1
SIDA	4,1	4,6	4,5	6,1	11,3	10,8
Streptocoques A invasifs	-	1,4	2,0	-	1,3	1,7
Streptocoques B invasifs	-	-	0,0	-	-	0,0
Streptocoques pneumoniae	-	-	0,0	-	-	0,2
Syphilis primaire	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Syphilis secondaire	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Syphilis latente (< 2 ans)	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
Syphilis latente (> 2ans)	1,2	0,0	0,0	0,9	0,7	0,6
Syphilis autre	0,2	0,0	0,0	0,3	0,2	0,1
Tétanos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Toxi-infection alimentaire	0,7	0,7	2,2	1,8	2,5	2,4
Trichinose	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose	2,2	2,3	0,7	5,3	5,5	4,9
Tularémie	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
TOTAL	**332,9**	**327,1**	**270,2**	**344,9**	**334,7**	**292,7**

MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
NOMBRE DE CAS DÉCLARÉS PAR CLSC
LAURENTIDES, 1996

MALADIE	CLSC							RÉGION DES LAURENTIDES
	Argenteuil	Arthur-Buies	Hautes-Laurentides	J.-O. Chénier	Pays-d'en-Haut	Thérèse-de-Blainv.	Trois-Vallées	
Amibiase	1	0	1	0	1	2	1	6
Campylobactériose	22	65	15	72	14	50	13	251
Chlamydiose génitale	13	85	51	130	23	61	17	380
Chlamydiose oculaire	1	0	0	0	0	0	0	1
Chlamydiose pulmonaire	0	0	0	1	0	0	0	1
Coqueluche	5	7	3	18	3	32	8	76
Diarrhée épidémique	0	1	0	0	0	0	0	1
Entérite à E. Coli	2	5	0	0	0	3	4	14
Entérite à Y. Enteroco.	2	6	0	6	1	4	2	21
Fièvre typhoïde	0	0	0	0	0	1	0	1
Fièvre Q	0	0	2	0	0	1	0	3
Giardiase	7	40	6	7	4	14	4	82
Hépatite A	2	9	3	4	2	7	1	28
Hépatite B aiguë	1	5	0	0	2	2	1	11
Hépatite B porteur	6	15	4	5	2	15	3	50
Inf. gonococ. gén.-urin.	1	2	1	1	1	1	1	8
Inf. à méningocoque	0	2	1	1	0	0	1	5
Légionellose	0	1	0	0	0	0	0	1
Méningite Coxsackie	0	0	0	3	0	1	0	4
Méningite sans précision	0	0	0	0	0	1	0	1
Oreillons	0	4	0	1	0	0	0	5
Paludisme	0	0	0	0	0	1	0	1
Rougeole	0	1	0	0	0	3	0	4
Salmonellose	9	33	18	24	8	19	8	119
Scarlatine	7	11	0	31	0	29	1	79
Shigellose	1	1	0	3	0	7	1	13
SIDA	3	5	1	5	2	3	1	20
Streptocoques A invasifs	1	1	0	1	3	2	1	9
Toxi-infection alimentaire	1	3	1	2	1	2	0	10
Tuberculose	0	0	1	1	0	1	0	3
TOTAL	**85**	**302**	**108**	**316**	**67**	**262**	**68**	**1208**

MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
INCIDENCE DE CAS DÉCLARÉS PAR 100 000 PERSONNES-ANNÉE PAR CLSC
LAURENTIDES, 1996

MALADIE	CLSC							RÉGION DES LAURENTIDES
	Argenteuil	Arthur-Buies	Hautes-Laurentides	J.-O. Chénier	Pays-d'en-Haut	Thérèse-de-Blainv.	Trois-Vallées	
Amibiase	3,4	0,0	3,0	0,0	3,8	1,5	2,9	1,3
Campylobactériose	75,6	65,3	44,9	77,9	52,8	38,0	37,5	56,2
Chlamydiose génitale	44,7	85,4	152,5	140,7	86,8	46,4	49,1	85,0
Chlamydiose oculaire	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Chlamydiose pulmonaire	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,2
Coqueluche	17,2	7,0	9,0	19,5	11,3	24,3	23,1	17,0
Diarrhée épidémique	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Entérite à E. Coli	6,9	5,0	0,0	0,0	0,0	2,3	11,5	3,1
Entérite à Y. Enteroco.	6,9	6,0	0,0	6,5	3,8	3,0	5,8	4,7
Fièvre typhoïde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,2
Fièvre Q	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,7
Giardiase	24,1	40,2	18,0	7,6	15,1	10,7	11,5	18,3
Hépatite A	6,9	9,1	9,0	4,3	7,5	5,3	2,9	6,3
Hépatite B aiguë	3,4	5,0	0,0	0,0	7,5	1,5	2,9	2,5
Hépatite B porteur	20,6	15,1	12,0	5,4	7,5	11,4	8,7	11,2
Inf. gonococ. gén.-urin.	3,4	2,0	3,0	1,1	3,8	0,8	2,9	1,8
Inf. à méningocoque	0,0	2,0	3,0	1,1	0,0	0,0	2,9	1,1
Légionellose	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Méningite Coxsackie	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,8	0,0	0,9
Méningite sans précision	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,2
Oreillons	0,0	4,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1
Paludisme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,2
Rougeole	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,9
Salmonellose	30,9	33,2	53,8	26,0	30,2	14,5	23,1	26,6
Scarlatine	24,1	11,1	0,0	33,6	0,0	22,1	2,9	17,7
Shigellose	3,4	1,0	0,0	3,3	0,0	5,3	2,9	2,9
SIDA	10,3	5,0	3,0	5,4	7,5	2,3	2,9	4,5
Streptocoques A invasifs	3,4	1,0	0,0	1,1	11,3	1,5	2,9	2,0
Toxi-infection alimentaire	3,4	3,0	3,0	2,2	3,8	1,5	0,0	2,2
Tuberculose	0,0	0,0	3,0	1,1	0,0	0,8	0,0	0,7
TOTAL	**292,2**	**303,6**	**323,0**	**342,0**	**252,7**	**199,3**	**196,3**	**270,2**

MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
NOMBRE DE CAS DÉCLARÉS PAR MOIS
LAURENTIDES, 1996

MALADIE	MOIS												TOTAL
	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DÉC	
Amibiase	1	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	6
Campylobactériose	17	17	14	16	15	19	23	42	31	22	20	15	251
Chlamydiose génitale	40	26	28	27	38	41	31	36	34	33	32	14	380
Chlamydiose oculaire	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Chlamydiose pulmonaire	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Coqueluche	6	4	15	5	3	2	2	9	5	7	13	5	76
Diarrhée épidémique	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Entérite à E. Coli	0	1	0	0	3	0	2	4	2	2	0	0	14
Entérite à Y. Enteroco.	1	0	1	2	2	2	2	7	2	1	1	0	21
Fièvre typhoïde	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Fièvre Q	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
Giardiase	5	6	12	14	6	7	5	9	8	6	0	4	82
Hépatite A	0	5	3	0	4	3	2	0	3	4	2	2	28
Hépatite B aiguë	0	0	1	0	1	0	3	2	2	0	1	1	11
Hépatite B porteur	2	7	2	6	5	2	5	4	0	9	4	4	50
Inf. gonococ. gén.-urin.	1	2	0	1	0	0	0	1	1	2	0	0	8
Inf. à méningocoque	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	5
Légionellose	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Méningite Coxsackie	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	4
Méningite sans précision	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Oreillons	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0	5
Paludisme	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Rougeole	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	4
Salmonellose	10	5	8	11	17	13	13	16	16	5	2	3	119
Scarlatine	13	9	13	8	7	6	1	1	2	4	8	7	79
Shigellose	0	1	1	2	3	2	1	0	0	0	2	1	13
SIDA	1	5	7	0	2	2	2	1	0	0	0	0	20
Streptocoques A invasifs	1	0	0	1	2	1	0	1	0	2	0	1	9
Toxi-infection alimentaire	0	0	1	2	1	1	0	0	1	1	1	2	10
Tuberculose	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3
TOTAL	**99**	**91**	**107**	**96**	**114**	**104**	**96**	**136**	**113**	**104**	**88**	**60**	**1208**

MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
NOMBRE DE CAS DÉCLARÉS SELON L'ÂGE ET LE SEXE
LAURENTIDES, 1996

MALADIE	GROUPE D'ÂGE																			
	< 1		1-4		5-9		10-14		15-19		20-24		25-29		30-39		40-59		60 +	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Amibiase	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	2	0	0	0
Campylobactériose	4	2	15	12	7	3	6	4	12	8	14	12	15	14	38	34	20	22	5	4
Chlamydiose génitale	0	0	0	0	0	0	0	6	11	121	36	99	17	30	13	29	7	10	0	1
Chlamydiose oculaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Chlamydiose pulmonaire	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coqueluche	1	2	10	15	11	19	1	7	0	2	0	0	0	1	2	0	1	3	0	1
Diarrhée épidémique	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entérite à E. Coli	0	1	2	2	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	2	1
Entérite à Y. Enteroco.	0	0	5	2	5	3	0	1	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0
Fièvre typhoïde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Fièvre Q	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0
Giardiase	0	0	9	5	4	5	3	1	1	4	2	2	3	6	7	7	7	10	2	4
Hépatite A	0	0	1	0	0	1	1	1	2	1	1	0	0	1	5	5	3	3	0	3
Hépatite B aiguë	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	2	0	0
Hépatite B porteur	0	3	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	3	1	11	4	10	10	3	2
Inf. gonococ. gén.-urin.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	1	1	0	1	0	0	0
Inf. à méningocoque	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Légionellose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

(Suite)

MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
NOMBRE DE CAS DÉCLARÉS SELON L'ÂGE ET LE SEXE
LAURENTIDES, 1996

MALADIE	GROUPE D'ÂGE																			
	< 1		1-4		5-9		10-14		15-19		20-24		25-29		30-39		40-59		60 +	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Méningite Coxsackie	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Méningite sans précision	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oreillons	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Peludisme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Rougeole	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Salmonellose	4	4	12	13	6	11	4	2	1	2	1	3	3	1	10	7	7	9	9	10
Scarlatine	0	0	22	11	16	24	0	1	0	1	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Shigellose	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	3	2	1	2	0	0
SIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	2	9	0	0	0
Streptocoques A invasifs	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0
Toxi-infection alimentaire	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	3	1	0	1	0	1
Tuberculose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	12	16	79	64	53	69	17	28	27	145	59	122	45	62	108	97	77	77	24	27

MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
INCIDENCE DE CAS DÉCLARÉS PAR 100 000 PERSONNES-ANNÉE,
SELON L'ÂGE ET LE SEXE, LAURENTIDES, 1996

MALADIE	GROUPE D'ÂGE																			
	< 1		1-4		5-9		10-14		15-19		20-24		25-29		30-39		40-59		60 +	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Amibiase	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	4,6	2,3	3,3	0,0	0,0	0,0
Campylobactériose	131,4	69,7	113,9	96,6	42,6	18,8	38,6	27,0	78,6	55,9	103,8	94,5	99,4	93,5	87,0	78,9	33,0	37,9	17,9	12,0
Chlamydiose génitale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,6	72,1	845,8	267,0	779,8	112,6	200,2	29,8	67,3	11,5	17,2	0,0	3,0
Chlamydiose oculaire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0
Chlamydiose pulmonaire	0,0	34,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche	32,8	69,7	75,9	120,7	66,9	119,0	6,4	47,3	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	6,7	4,6	0,0	1,7	5,2	0,0	3,0
Diarrhée épidémique	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entérite à E. Coli	0,0	34,8	15,2	16,1	6,1	0,0	6,4	0,0	0,0	7,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7	7,2	3,0
Entérite à Y. Enteroco.	0,0	0,0	38,0	16,1	30,4	18,8	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	7,9	6,6	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fièvre typhoïde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Fièvre Q	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	1,7	3,6	0,0
Giardiase	0,0	0,0	68,3	40,3	24,3	31,3	19,3	6,8	6,6	28,0	14,8	15,8	19,9	40,1	16,0	16,3	11,5	17,2	7,2	12,0
Hépatite A	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	6,3	6,4	6,8	13,1	7,0	7,4	0,0	0,0	6,7	11,4	11,6	4,9	5,2	0,0	9,0
Hépatite B aiguë	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	7,0	6,6	3,5	0,0	0,0
Hépatite B porteur	0,0	104,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	7,0	0,0	0,0	19,9	6,7	25,2	9,3	16,5	17,2	10,7	6,0
Inf. gonococ. gén.-urin.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3	0,0	13,3	6,7	2,3	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0
Inf. à méningocoque	32,8	34,8	7,6	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0
Légionellose	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Méningite Coxsackie	32,8	69,7	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(Suite)

MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
INCIDENCE DE CAS DÉCLARÉS PAR 100 000 PERSONNES-ANNÉE,
SELON L'ÂGE ET LE SEXE, LAURENTIDES, 1996

MALADIE	GROUPE D'ÂGE																			
	< 1		1-4		5-9		10-14		15-19		20-24		25-29		30-39		40-59		60 +	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Méningite sans précision	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Oreillons	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7	0,0	0,0
Paludisme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole	0,0	0,0	0,0	8,1	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Salmonellose	131,4	139,4	91,1	104,6	36,5	68,9	25,7	13,5	6,6	14,0	7,4	23,6	19,9	6,7	22,9	16,3	11,5	15,5	32,2	29,9
Scarlatine	0,0	0,0	167,1	88,6	97,3	150,3	0,0	6,8	0,0	7,0	0,0	15,8	0,0	0,0	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Shigellose	0,0	0,0	0,0	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	7,9	0,0	0,0	6,9	4,6	1,7	3,5	0,0	0,0
SIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	6,7	16,0	4,6	14,8	0,0	0,0	0,0
Streptocoques A invasifs	0,0	0,0	7,6	0,0	6,1	0,0	0,0	6,8	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	6,7	2,3	0,0	1,7	1,7	3,6	0,0
Toxi-infection alimentaire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,9	2,3	0,0	1,7	0,0	3,0
Tuberculose	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	3,6	0,0
TOTAL	**394,1**	**557,5**	**599,9**	**515,2**	**322,2**	**432,2**	**109,2**	**189,3**	**176,9**	**1013,6**	**437,5**	**961,0**	**298,1**	**413,8**	**247,1**	**225,2**	**126,9**	**132,7**	**85,8**	**80,8**

I 12,021
1996
ex.2

E-1103

Provost, S. et al.

Rapport sur les maladies à déclaration obligatoire : région des Laurentides 1996

DATE	NOM

I 12,021
1996
ex.2